

# *Buku Referensi* **PENTINGNYA KESEHATAN MENTAL DALAM KEHAMILAN**

Yuliana Dafroyati • Vivi Dwi Putri • Frani Mariana  
Fatihah Wari Nurjanah • Yuni Purwati





# **BUKU REFERENSI**

## **PENTINGNYA KESEHATAN MENTAL**

### **DALAM KEHAMILAN**

Yuliana Dafroyati, S.Kep., Ns, M.Sc.

Vivi Dwi Putri, S.ST., M.Kes.

Frani Mariana, SST., M. Keb.

Fatihah Wari Nurjanah, M.Tr.Keb.

Dr. Yuni Purwati, S.Kep., Ns., M.Kep.



**Optimal  
Untuk  
Negeri**

# **BUKU REFERENSI**

## **PENTINGNYA KESEHATAN MENTAL DALAM KEHAMILAN**

**Penulis:** Yuliana Dafroyati, S.Kep., Ns, M.Sc.

Vivi Dwi Putri, S.ST., M.Kes.

Frani Mariana, SST., M. Keb.

Fatihah Wari Nurjanah, M.Tr.Keb.

Dr. Yuni Purwati, S.Kep., Ns., M.Kep.

**Desain Sampul:** Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

**Penata Letak:** Ivan Zumarano

**ISBN:** 978-623-10-9829-0

**Cetakan Pertama:** Mei, 2025

Hak Cipta 2025

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

**Copyright © 2025**

**Penerbit Optimal Untuk Negeri**

*All Right Reserved*

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

# Prakata

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan bimbingan-Nya, sehingga buku referensi yang berjudul "**Pentingnya Kesehatan Mental dalam Kehamilan**" ini dapat tersusun dengan baik. Buku ini disusun sebagai wujud kontribusi kami dalam mendukung kesehatan ibu hamil, khususnya kesehatan mental yang seringkali terabaikan dalam proses kehamilan. Kehamilan tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga berbagai tantangan fisik, emosional, dan psikologis yang membutuhkan perhatian khusus.

Dalam buku ini, kami berupaya menyajikan berbagai aspek penting seputar kesehatan mental ibu hamil, mulai dari faktor risiko yang dapat memicu gangguan mental, pentingnya dukungan emosional dari lingkungan sekitar, hingga pemanfaatan aktivitas fisik dan teknologi dalam menjaga keseimbangan mental selama kehamilan. Dengan latar belakang keilmuan yang beragam, para penulis telah berkolaborasi untuk menghadirkan informasi yang ilmiah, aktual, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca, khususnya praktisi kesehatan, akademisi, dan masyarakat umum.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan. Untuk itu, ucapan terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan, penerbitan, hingga distribusi buku ini. Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran dan kualitas kesehatan mental ibu hamil di Indonesia.

**Penulis**

# Daftar Isi

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Prakata .....</b>                                                              | <b>iii</b> |
| <b>Daftar Isi.....</b>                                                            | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I FAKTOR RISIKO GANGGUAN MENTAL PADA IBU HAMIL. ....</b>                   | <b>1</b>   |
| A.Pendahuluan.....                                                                | 1          |
| B.Perubahan psikologis pada ibu hamil .....                                       | 2          |
| C.Kesehatan mental pada masa kehamilan .....                                      | 5          |
| D.Faktor Risiko Gangguan mental pada Ibu Hamil .....                              | 7          |
| E.Penutup .....                                                                   | 8          |
| Referensi10                                                                       |            |
| <b>BAB II EDUKASI TENTANG PENTINGNYA DUKUNGAN EMOSIONAL SELAMA KEHAMILAN.....</b> | <b>13</b>  |
| A.Pendahuluan.....                                                                | 13         |
| B.Faktor yang mempengaruhi Dukungan Emosional. ....                               | 15         |
| C.Manfaat Dukungan Emosional Selama Kehamilan. ....                               | 16         |
| D.Bentuk Dukungan Emosional Ibu selama hamil .....                                | 17         |
| E.Strategi Meningkatkan Dukungan Emosional Selama hamil .....                     | 18         |
| F.Penutup .....                                                                   | 19         |
| Referensi20                                                                       |            |
| <b>BAB III AKTIVITAS FISIK YANG MENDUKUNG KESEIMBANGAN MENTAL IBU HAMIL.....</b>  | <b>24</b>  |
| A.Pendahuluan.....                                                                | 24         |
| B.Prenatal Yoga .....                                                             | 25         |
| C.Tari ( <i>Dance</i> ).....                                                      | 27         |
| D.Latihan Ketahanan ( <i>Resistance Training</i> ).....                           | 28         |
| E.Berjalan ( <i>Walking</i> ).....                                                | 29         |
| F.Berlari ( <i>Running</i> ).....                                                 | 30         |
| G.Senam Hamil ( <i>pregnancy exercises</i> ).....                                 | 31         |
| H.Meditasi ( <i>Meditation</i> ).....                                             | 32         |
| I.Teknik Pernapasan ( <i>Breathing techniques</i> ).....                          | 33         |
| J.Akupresur dan refleksiologi ( <i>Acupressure and reflexology</i> ) .....        | 35         |
| K. <i>Tai Chi for physical and Mental Health</i> .....                            | 36         |
| L.Penutup .....                                                                   | 37         |
| Referensi38                                                                       |            |
| <b>BAB IV PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK LAYANAN KONSELING JARAK JAUH .....</b>      | <b>41</b>  |
| A.Pendahuluan.....                                                                | 41         |
| B.Konsep Dasar Konseling Jarak Jauh .....                                         | 42         |
| C.Metode dan Teknik Konseling Jarak Jauh .....                                    | 44         |
| D.Tantangan dan Solusi dalam Konseling Jarak Jauh.....                            | 46         |
| E.Strategi Efektif dalam Konseling Jarak Jauh.....                                | 48         |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| F.Implementasi Konseling Jarak Jauh .....                             | 50        |
| G.Penutup .....                                                       | 52        |
| Referensi                                                             | 53        |
| <b>BAB V DUKUNGAN KELUARGA DALAM MENJAGA KESEHATAN MENTAL IBU</b>     |           |
| <b>HAMIL.....</b>                                                     | <b>54</b> |
| A.Pendahuluan.....                                                    | 54        |
| B.Konsep Dukungan Keluarga Pada Ibu Hamil .....                       | 55        |
| C.Dukungan Keluarga dalam Teori <i>Maternal Role Attainment</i> ..... | 57        |
| D.Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga .....             | 59        |
| E.Manfaat Dukungan Keluarga Pada Ibu Hamil .....                      | 59        |
| F.Bentuk Dukungan Keluarga Pada Ibu Hamil .....                       | 60        |
| G. <i>Evidenced Based</i> Dukungan Keluarga Pada Ibu Hamil .....      | 63        |
| H.Penutup .....                                                       | 68        |
| Referensi                                                             | 69        |
| <b>Profil Penulis.....</b>                                            | <b>75</b> |



# BAB I

## FAKTOR RISIKO GANGGUAN MENTAL PADA IBU HAMIL.

---

### A. Pendahuluan

---

Kehamilan adalah sebuah peristiwa yang membahagiakan terutama bagi pasangan suami dan istri. Namun demikian, kehamilan merupakan masa meningkatnya kerentanan untuk berkembangnya kecemasan dan depresi (Biaggi, Conroy, Pawlby, & Pariante, 2016). Kondisi ini terjadi, karena seiring dengan kehamilannya, seorang wanita hamil mengalami banyak perubahan fisik, diikuti perubahan psikologi yang mengakibatkan kondisi emosi tidak stabil. Perubahan emosi yang tidak stabil ini berdampak pada perkembangan janin, lahir prematur, berat bayi lahir rendah dan menjadi emosional bayi setelah lahir (Gelaye, Rondon, Araya, Williams, & Author, 2016; Ibanez et al., 2015; Saeed, Raana, Saeed, & Humayun, 2016). Hal yang sering membuat kondisi lebih parah adalah wanita hamil sering tidak menyadari bahwa dirinya mengalami gangguan mental, suami dan keluarga kadang juga tidak mengetahui kondisi psikologi wanita hamil yang labil, sehingga kurang memberikan perhatian dan dukungan. Hal ini menyebabkan gejala gangguan jiwa pada wanita hamil tidak tertangani dan dapat memburuk hingga masa nifas dan menimbulkan baby blues bahkan depresi postpartum (Elsenbruch et al., 2007).

*World Health Organization* (WHO) mencatat, sekitar 13% ibu hamil mengalami gangguan kecemasan, umumnya depresi. Di negara-negara berkembang, persentasenya bahkan bisa mencapai 19,8%. Sejalan dengan temuan penelitian Honikman, WHO juga menyatakan bahwa depresi yang mengarahkan pada ide bunuh diri pada perempuan rentan terjadi setelah kelahiran bayinya. Tidak cuma ide bunuh diri saja yang timbul sebagai efek depresi pasca- melahirkan. Kesulitan merespons kebutuhan bayi pun menjadi tanda lain seorang ibu mengalami depresi (Kirnandita, 2016).

Indonesia terdapat 373.000.000 ibu hamil sedangkan yang mengalami kecemasan dalam menghadapi proses persalinan ada sebanyak 107.000.000 ibu hamil (28,7%) (Arifin, 2015). Penelitian yang dilakukan Lee Lam Marie, Chong, Chui dan Fong dalam jurnal Yuliasari (2016), menunjukkan lebih dari setengah atau 54% dan lebih dari sepertiga atau 37% dari perempuan memiliki kecemasan saat sedang hamil dan gejala depresi, kecemasan lebih umum terjadi saat kehamilan hingga menjelang persalinan. Lebih dari 20% wanita hamil melaporkan ketakutan dan 6% menggambarkan rasa takut yang melumpuhkan. 13 % dari seluruh wanita yang tidak



hamil melaporkan rasa takut akan persalinan sehingga cukup untuk menunda atau menghindari kehamilan (Yuliasari, 2016).

Selama kehamilan kebanyakan wanita mengalami perubahan psikologis dan emosional. Perubahan fisik dan emosional yang kompleks, memerlukan adaptasi terhadap penyesuaian pola hidup dengan proses kehamilan yang terjadi. Menurut hasil penelitian Astria (2009) sejak saat hamil, ibu sudah mengalami kecemasan. Kecemasan meningkat menjelang persalinan terutama pada trimester III. Pada ibu hamil trimester III umumnya mengalami kecemasan dalam menghadapi persalinan (52,5%) dan sisanya tidak mengalami kecemasan (47,5%) (Istikhomah, 2015).

Reaksi psikologis dalam kehamilan yang terjadi yaitu reaksi cemas, gangguan ini ditandai dengan rasa cemas dan kebutuhan yang berlebihan terutama sekali pada hal-hal yang masih tergolong wajar. Reaksi panik juga timbul dalam periode yang relative singkat tanpa sebab yang jelas, reaksi obsesif komulatif selalu timbul perasaan, rangsangan, atau pikiran. Reaksi ini dapat terjadi pada ibu yang kurang mendapat perhatian dari suami atau keluarga yang lain (Bahiyatun 2014). Kehamilan dan persalinan merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan perubahan pada tubuh secara fisiologis maupun psikologis seorang wanita, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian terhadap perubahan tersebut (Nirwana, 2011)

## **B. Perubahan psikologis pada ibu hamil**

---

### **1. Perubahan psikologis pada ibu hamil trimester I**

Trimester I ini disebut sebagai masa penentuan artinya penentuan untuk membuktikan bahwa wanita dalam keadaan hamil. Seorang ibu setelah mengetahui dirinya hamil maka responnya berbeda - beda. Sikap ambivalent sering dialami pada ibu hamil, artinya kadang - kadang ibu merasa senang dan bahagia karena segera akan menjadi ibu dan orangtua, tetapi tidak sedikit juga ibu hamil merasa sedih dan bahkan kecewa setelah mengetahui dirinya hamil. Perasaan sedih dan kecewa ini dapat disebabkan oleh karena segera setelah konsepsi kadar hormon progesterone dan estrogen dalam kehamilan akan meningkat dan ini akan Perubahan Psikologis Pada Ibu Hamil menyebabkan timbulnya mual dan muntah pada pagi hari, lemah, lelah, dan membesarnya payudara. Ibu merasa tidak sehat sehingga seringkali membenci kehamilannya. Pada trimester pertama seorang ibu akan selalu mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya memang hamil. Setiap perubahan yang terjadi pada tubuhnya akan selalu diperhatikan dengan seksama. Sikap ibu terhadap suami atau terhadap orang lain juga berbeda-beda, kadang ingin merahasiakannya, hal ini bisa terjadi karena memang perutnya masih kecil dan belum kelihatan membesar, tapi ada juga ibu yang ingin segera memberitahukan kehamilannya kepada suami atau orang lain. Hasrat untuk melakukan hubungan sex, pada wanita trimester pertama ini juga berbeda.

## **2 Pentingnya Kesehatan Mental Dalam Kehamilan**

Walaupun beberapa wanita mengalami gairah sex yang lebih tinggi, kebanyakan mereka mengalami penurunan libido selama periode ini disebabkan ibu hamil trimester I masih sering mengalami mual muntah sehingga merasa tidak sehat. Keadaan ini menciptakan kebutuhan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan suami. Banyak wanita merasa butuh untuk dicintai dan merasakan kuat untuk mencintai namun tanpa berhubungan sex. Libido sangat dipengaruhi oleh kelelahan, rasa mual, pembesaran payudara, keprihatinan, dan kekhawatiran. Semua ini merupakan bagian normal dari proses kehamilan pada trimester pertama. Perasaan ibu hamil akan stabil setelah ibu sudah bisa menerima kehamilannya sehingga setiap ibu akan berbeda-beda.

Bagaimana reaksi suami setelah mengetahui istrinya hamil? Reaksi pertama seorang pria ketika mengetahui bahwa dirinya akan menjadi ayah adalah timbulnya kebanggaan atas kemampuannya mempunyai keturunan bercampur dengan keprihatinan akan kesiapan untuk menjadi seorang ayah dan mencari nafkah untuk keluarganya. Seorang calon ayah mungkin akan sangat memperhatikan keadaan ibu yang sedang mulai hamil dan menghindari hubungan seks karena takut akan mencederai bayinya. Adapula pria yang hasrat seksnya terhadap wanita hamil relatif lebih besar. Disamping respon yang diperlihatkannya, seorang ayah perlu dapat memahami keadaan ini dan menerimanya.

## **2. Perubahan psikologis pada ibu hamil trimester II.**

Trimester II ini sering disebut sebagai periode pancaran kesehatan karena pada saat ini ibu merasa lebih sehat. Trimester kedua biasanya adalah saat ibu merasa sehat. Tubuh ibu sudah terbiasa dengan kadar hormon yang lebih tinggi dan rasa tidak nyaman karena hamil sudah berkurang. Perut ibu belum terlalu besar sehingga belum dirasakan sebagai beban. Ibu sudah menerima kehamilannya dan mulai dapat menggunakan energi dan pikirannya secara lebih konstruktif. Pada trimester ini pula ibu dapat merasakan gerakan bayinya dan ibu mulai merasakan kehadiran bayinya sebagai seorang diluar dari dirinya sendiri. Banyak ibu yang merasa terlepas dari rasa kecemasan, rasa tidak nyaman seperti yang dirasakannya pada trimester pertama dan merasakan meningkatnya libido. Ibu merasa lebih stabil, kesanggupan mengatur diri lebih baik, kondisi atau keadaan ibu lebih menyenangkan, ibu mulai terbiasa dengan perubahan fisik tubuhnya, janin belum terlalu besar sehingga belum menimbulkan ketidaknyamanan. Ibu sudah mulai menerima dan mengerti tentang kehamilannya.

Pada beberapa ibu hamil akan menjadi sedikit pelupa selama kehamilannya, Ada beberapa teori tentang hal ini karena tubuh ibu terus bekerja

berlebihan untuk perkembangan bayinya sehingga menimbulkan blok pikiran. Tak perlu terpengaruh dengan hal ini, sediakan catatan kecil untuk membantu anda. Dan beristirahalah sedapat mungkin. Pada kehamilan minggu ke 15-22 ibu hamil akan mulai merasakan gerakan bayi yang awalnya akan terasa seperti kibasan tetapi di akhir trimester II akan benar-benar merasakan pergerakan bayi. Pada ibu yang baru pertama kali sering tidak dapat mengenali gerakan bayinya sampai minggu ke 19-22. Pada saat ibu sudah merasakan gerakan bayinya, ibu menyadari bahwa didalam dirinya ada individu lain sehingga ibu lebih memperhatikan kesehatan bayinya. Pada saat ini jenis kelamin bayi belum menjadi perhatian. Suami lebih giat mencari uang karena menyadari bahwa tanggung jawabnya semakin bertambah untuk menyiapkan kebutuhan biaya melahirkan dan perlengkapan untuk istri dan bayinya. Pada semester ini perut ibu sudah semakin kelihatan membesar karena uterus sudah keluar dari panggul, membuat suami semakin bersemangat. Hal ini juga dipengaruhi oleh karena suami merasakan gerakan bayinya ketika meraba perut istrinya.

### **3. Perubahan psikologis pada ibu hamil trimester III**

Trimester ketiga seringkali disebut periode menunggu dan waspada sebab pada saat itu ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya. Gerakan bayi dan membesarnya perut merupakan dua hal yang mengingatkan ibu akan bayinya. Kadang -kadang ibu merasa khawatir bahwa bayinya akan lahir sewaktu - waktu. Ini menyebabkan ibu meningkatkan kewaspadaannya akan timbulnya tanda dan gejala akan terjadinya persalinan. Ibu seringkali merasa khawatir pada bayi yang akan dilahirkannya tidak normal. Kebanyakan ibu juga akan bersikap melindungi bayinya dan akan menghindari orang atau benda apa saja yang dianggapnya membahayakan bayinya. Seorang ibu mungkin mulai merasa takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang akan timbul pada waktu melahirkan. Rasa tidak nyaman akibat kehamilan timbul kembali pada trimester ketiga dan banyak ibu yang merasa dirinya aneh dan jelek. Disamping itu, ibu mulai merasa sedih karena akan berpisah dari bayinya dan kehilangan perhatian khusus yang diterima selama hamil. Pada trimester inilah ibu sangat memerlukan keterangan dan dukungan dari suami, keluarga dan bidan. Trimester ketiga adalah saat persiapan aktif untuk kelahiran bayi dan menjadi orang tua. Periode ini juga disebut periode menunggu dan waspada sebab merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya.

Gerakan bayi dan membesarnya perut merupakan 2 hal yang mengingatkan ibu pada bayi yang akan dilahirkan nanti. Disamping hal tersebut ibu sering mempunyai perasaan :

- a. Kadang-kadang merasa kuatir bahwa bayinya akan lahir sewaktu – waktu
- b. Meningkatnya kewaspadaan akan timbulnya tanda dan gejala persalinan

- c. Khawatir bayinya lahir dalam keadaan tidak normal
- d. Takut akan rasa sakit yang timbul pada saat persalinan
- e. Rasa tidak nyaman
- f. Kehilangan perhatian khusus yang diterima selama kehamilan sehingga memerlukan dukungan baik dari suami, keluarga maupun tenaga kesehatan
- g. Persiapan aktif untuk bayi dan menjadi orang tua

Keluarga mulai mempertanyakan tentang jenis kelamin bayinya ( apakah laki - laki atau perempuan ) dan akan mirip siapa. Bahkan mereka mungkin juga sudah memilih sebuah nama untuk bayinya.

Berat badan ibu meningkat, adanya tekanan pada organ dalam, adanya perasaan tidak nyaman karena janinnya semakin besar, adanya perubahan gambaran diri ( konsep diri, tidak mantap, merasa terasing, tidak dicintai, merasa tidak pasti, takut, juga senang karena kelahiran sang bayi ).

Adanya kegembiraan emosi karena kelahiran bayi. Sekitar bulan ke-8 mungkin terdapat periode tidak semangat dan depresi, ketika bayi membesar dan ketidaknyamanan bertambah. Calon ibu mudah lelah dan menunggu dampaknya terlalu lama. Sekitar 2 minggu sebelum melahirkan, sebagian besar wanita mulai mengalami perasaan senang. Mereka mungkin mengatakan pada perawat "saya merasa lebih baik saat ini ketimbang sebulan yang lalu". Kecuali bila berkembang masalah fisik, kegembiraan ini terbawa sampai proses persalinan, suatu periode dengan stress yang tinggi. Reaksi calon ibu terhadap persalinan ini secara umum tergantung pada persiapan dan persepsinya terhadap kejadian ini. Perasaan sangat gembira yang dialami ibu seminggu sebelum persalinan mencapai klimaksnya sekitar 24 jam sebelum persalinan.

### **C. Kesehatan mental pada masa kehamilan**

---

Menurut Federasi Kesehatan Mental Dunia (*World Federation for Mental Health*) menjelaskan pengertian dari kesehatan mental sebagai kondisi yang memungkinkan adanya perkembangan yang baik secara fisik, intelektual dan emosional, sepanjang hal itu sesuai dengan keadaan orang lain.

Kesehatan mental adalah kondisi dimana seseorang memiliki kesejahteraan yang terlihat dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup dan normal di setiap situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya.

Munculnya perasaan cemas dan bingung merupakan hal yang wajar bagi seseorang yang menjalani kehamilan atau ketika segera akan melahirkan. Namun sumber stress tersebut dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami

masalah kesehatan mental, seperti depresi dan gangguan psikosis. Risiko tersebut juga jauh lebih tinggi jika ibu hamil memiliki riwayat gangguan kesehatan mental serius sebelumnya.

Hal - hal yang dapat memicu masalah kesehatan mental pada kehamilan :

- 1) Kehamilan pada usia remaja
- 2) Pengalaman mengalami trauma – fisik, emosi ataupun kekerasan seksual
- 3) Riwayat ketergantungan obat, termasuk perilaku merokok
- 4) Kurangnya dukungan sosial
- 5) Menjadi orang tua tunggal saat hamil
- 6) Memiliki tingkat sosio-ekonomi rendah
- 7) Pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga
- 8) Pengobatan depresi yang tidak tuntas
- 9) Mengalami kesulitan finansial
- 10) Memiliki pemikiran yang bertentangan akan kehamilannya.

Adapun beberapa masalah kesehatan mental yang bisa terjadi pada masa kehamilan :

### **1. Depresi**

Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang paling umum pada masa kehamilan. Hal ini sering menjadi pemicu, dan muncul bersamaan dengan gejala gangguan kesehatan mental lainnya seperti gangguan kecemasan, obsessive-compulsive disorder, dan gangguan pola makan.

### **2. Panic Disorder ( kepanikan / kecemasan berlebih )**

Gangguan yang dapat muncul saat masa kehamilan meskipun wanita tersebut tidak memiliki riwayat pernah menderita panic disorder. Hal ini dapat muncul dari rasa cemas dan stress yang ditandai dengan peningkatan hormon kortisol ( hormon yang keluar ketika Anda merasa cemas ).

Jika tidak ditangani, peningkatan kortisol dapat mempengaruhi perkembangan janin dalam kandungan. Penanganan tanpa obat dapat dilakukan dengan cara terapi perilaku kognitif dan supportif, menerapkan teknik relaksasi, penerapan sleep hygiene ,serta pengaturan pola makan.

### **3. Obsesive-Compulsive Disorder ( OCD )**

OCD adalah gangguan berupa obsesi dan kebiasaan berulang yang sulit dikendalikan, yang dapat muncul di periode awal masa kehamilan, dan meningkat seiring masa kehamilan hingga pasca melahirkan.

### **4. Gangguan Pola Makan**

Meskipun hal ini cenderung membaik saat masa kehamilan, namun gangguan pola masih dapat terjadi saat masa kehamilan. Gangguan pola makan bukan hanya dapat mempengaruhi kesiapan ibu hamil untuk melahirkan normal, tapi juga dapat meningkatkan risiko depresi pascamelahirkan serta dapat berdampak melahirkan bayi berat lahir rendah.

## **5. Gangguan Bipolar**

Bipolar disorder merupakan gangguan yang terjadi secara kambuhan pada ibu hamil, namun kejadiannya lebih sering terjadi pasca melahirkan.

## **6. Skizofrenia**

Skizofrenia adalah gangguan psikosis yang dapat meningkat ataupun menurun pada masa kehamilan. Ibu hamil dengan gangguan ini membutuhkan pengawasan dan penanganan oleh dokter.

Skizofrenia berdampak pada kesehatan ibu dan bayi akibat mendapat perawatan yang tidak sesuai, bisa memicu lahir prematur dan berat lahir rendah, hingga kematian janin dan ibu hamil.

## **D. Faktor Risiko Gangguan mental pada Ibu Hamil**

---

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang ditemukan tentang faktor risiko yang mempengaruhi keadaan mental ibu hamil.

### **1. Dukungan Keluarga**

Kurangnya dukungan suami dan keluarga merupakan faktor penyebab terganggunya psikis ibu dimasa kehamilannya, ibu hamil dengan dukungan suami dan keluarga yang kurang ini dapat menyebabkan ibu merasa jika dirinya dan kehamilannya tidak begitu berarti bagi suami dan keluarganya, dengan demikian ibu hamil akan mengalami stres karna merasa dirinya tidak penting dimata suami dan keluarganya (Stepowicz et al., 2020).

Dalam Penelitian Martini tahun 2014 dalam penelitiannya mengatakan dukungan suami memiliki pengaruh sekitar 6,013 kali mengalami depresi postpartum dibandingkan dengan ibu yang memperoleh dukungan yang baik oleh suami (Arimurti et al., 2020).

### **2. Status Ekonomi**

Penelitian (Tang et al., 2019) dalam studinya menunjukkan bahwa penyebab stres pada wanita masa prenatal ringan hingga sedang yang dialami oleh ibu hamil yang ditemukan terkait dengan pendapatan rumah tangga. Penelitian lain juga menemukan bahwa munculnya gejala stres dan kecemasan prenatal berhubungan dengan status ibu rumah tangga atau wanita yang tidak



bekerja (Rusli et al., 2011), selama kehamilan memiliki risiko stres dan kecemasan prenatal yang lebih tinggi dari pada mereka yang tetap bekerja (San Lazaro Campillo et al., 2017). Keluar dari pekerjaan dapat berarti tekanan ekonomi yang lebih besar, lebih banyak konflik keluarga, status sosial ekonomi yang lebih rendah, perilaku yang lebih tidak sehat (seperti minum dan merokok), kesepian karena banyak waktu luang tanpa pendamping, dan rasa keterikatan karena ketergantungan ekonomi (San Lazaro Campillo et al., 2017). Ekonomi dikaitkan dengan kejadian stress pada ibu dengan cara dan gaya hidup seseorang (Muzakkir et al., 2019). Ekonomi dapat menjadi pencetus depresi dalam kehamilan adalah faktor sosial ekonomi berupa gaya hidup (Kusuma, 2019).

1. Lingkungan Sosial

Lingkungan dan dukungan sosial selama kehamilan sangat diperlukan karena dapat mengurangi kepekaan biologis terhadap stres psikologis (Keskin et al., 2022), dukungan sosial dianggap mampu memberikan penguatan terhadap kepercayaan ibu selama masa kehamilannya dan juga dapat memberikan gambaran positif tentang apa yang dijalani oleh ibu hamil, dukungan sosial juga mampu mengurangi kecemasan ibu hamil saat dirinya akan menghadapi persalinan (Fathnezhad-Kazemi & Hajian, 2019).

2. Pengalaman dan Pengetahuan

Pengetahuan ibu hamil sangat mempengaruhi kondisi psikis dimasa kehamilan, ibu hamil yang pengetahuannya kurang tentang kehamilan, persalinan dan juga cara pengasuhan bayi setelah melahirkan ini merupakan penyebab kecemasan yang dapat dialami oleh ibu hamil (Lagadec et al., 2018). Ibu hamil pertama kali tingkat ketakutan yang dirasakan akan lebih besar dibandingkan dengan ibu yang sudah pernah melahirkan sebelumnya (Stepowicz et al., 2020), ibu hamil pertama lebih sering mengalami kecemasan, stres, ketakutan hingga depresi saat masa kehamilan (Giarratano et al., 2019).

## **E. Penutup**

---

Ibu hamil merupakan kelompok yang rentan mengalami gangguan psikologis selama kehamilannya, serta memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi dalam menghadapi kehamilan hingga persalinan. Gangguan psikologis pada ibu hamil akan memberikan efek yang besar terhadap perawatan kehamilan, perkembangan janin dalam kandungan sampai dengan proses persalinan dan masa nifas. Tingginya kecemasan dan depresi pada ibu hamil disebabkan oleh beberapa faktor dan berdampak pada kesehatan mental.

Dalam pembahasan faktor risiko yang dapat menimbulkan gangguan mental pada ibu hamil yaitu, status dukungan suami dan keluarga, status ekonomi, lingkungan sosial dan juga pengalaman serta pengetahuan ibu. Pentingnya upaya

yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang bagaimana cara dalam penanganan stres dimasa kehamilan dan juga pada dukungan keluarga selama kehamilan bisa dilakukan pemberian edukasi terhadap ibu hamil tentang pentingnya menjaga kesehatan mental selama kehamilan.

## Referensi

- Arimurti, I. S., PRATIWI, R. D., & Ramadhina, A. R. (2020). Studi Literatur Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Depresi Post Partum. *Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 29. <https://doi.org/10.52031/edj.v4i2.53>
- Fathnezhad-Kazemi, A., & Hajian, S. (2019). *Factors influencing the adoption of healthpromoting behaviors in overweight pregnant women: A qualitative study*. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12884-019-2199-5>
- Franks, W. L. M., Crozier, K. E., & Penhale, B. L. M. (2017). *Women's mental health during pregnancy: A participatory qualitative study*. *Women and Birth*, 30(4), e179–e187. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2016.11.007>
- Giarratano, G. P., Barcelona, V., Savage, J., & Harville, E. (2019). *Mental health and worries of pregnant women living through disaster recovery*. *Health Care for Women International*, 40(3), 259–277. <https://doi.org/10.1080/07399332.2018.1535600>
- Keskin, G., Gümüşsoy, S., & Yıldırım, G. (2022). *Assessment of mental health issues in pregnant women with fetal complications: Relation to attachment and anxiety*. *Perspectives in Psychiatric Care*, 58(3), 994–1002. <https://doi.org/10.1111/ppc.12890>
- Kusuma, R. (2019). Karakteristik Ibu Yang Mengalami Depresi Dalam Kehamilan. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 8(1), 99. <https://doi.org/10.36565/jab.v8i1.107>
- Lagadec, N., Steinecker, M., Kapassi, A., Magnier, A. M., Chastang, J., Robert, S., Gaouaou, N., & Ibanez, G. (2018). Factors influencing the quality of life of pregnant women: A systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12884-018-2087-4>
- Liu, J., Hung, P., Alberg, A. J., Hair, N. L., Whitaker, K. M., Simon, J., & Taylor, S. K. (2021). *Mental health among pregnant women with COVID-19-related stressors and worries in the United States*. *Birth*, 48(4), 470–479. <https://doi.org/10.1111/birt.12554>
- Montagnoli, C., Zanconato, G., Cinelli, G., Tozzi, A. E., Bovo, C., Bortolus, R., & Ruggeri, S. (2020). *Maternal mental health and reproductive outcomes: a scoping review of the current literature*. *Archives of Gynecology and Obstetrics*, 302(4), 801–819. <https://doi.org/10.1007/s00404-020-05685-1>
- Muzakkir, M., Azniah, A., & Aminah, S. (2019). *Hubungan Antara Faktor Sosiodemografi Dengan Potensi Kejadian Depresi Maternal Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Pampang Kota Makassar*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 14(2), 199–203. <https://doi.org/10.35892/jikd.v14i2.229>

- Pham, M. T., Rajić, A., Greig, J. D., Sargeant, J. M., Papadopoulos, A., & Mcewen, S. A. (2014). *A scoping review of scoping reviews: Advancing the approach and enhancing the consistency. Research Synthesis Methods*, 5(4), 371–385. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1123>
- Roof, K. A., James-hawkins, L., Rahim, H. F. A., & Yount, K. M. (2019). *Validation of three mental health scales among pregnant women in Qatar*. 1–6.
- Rusli, R. A., Meiyuntariningsih, T., & Warni, W. E. (2011). Perbedaan Depresi Pasca Melahirkan pada Ibu Primipara Ditinjau dari Usia Ibu hamil. 13(01), 21–31. [http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/artikel 3-13-1.pdf](http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/artikel%203-13-1.pdf)
- San Lazaro Campillo, I., Meaney, S., McNamara, K., & O'Donoghue, K. (2017). *Psychological and support interventions to reduce levels of stress, anxiety or depression on women's subsequent pregnancy with a history of miscarriage: An empty systematic review. BMJ Open*, 7(9). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-017802>
- Sapkota, D., Baird, K., Saito, A., Rijal, P., & Anderson, D. (2022). *Antenatal-Based Pilot Psychosocial Intervention to Enhance Mental Health of Pregnant Women Experiencing Domestic and Family Violence in Nepal. Journal of Interpersonal Violence*, 37(5–6), NP3605–NP3627. <https://doi.org/10.1177/0886260520948151>
- Sartika, Hikmah, N., & Sani, A. (2021). Gambaran Kesehatan Mental Ibu. *Kampurui Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3(2), 61–68.
- Shahid, A., Malik, N. I., Shahid, F., Ullah, I., & Abbass, Z. (2022). *Psychosocial predictors of mental health among pregnant women. Perspectives in Psychiatric Care*, 58(3), 1071–1076. <https://doi.org/10.1111/ppc.12900>
- Stepowicz, A., Wencka, B., Bieńkiewicz, J., Horzelski, W., & Grzesiak, M. (2020). *Stress and anxiety levels in pregnant and post-partum women during the COVID-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(24), 1–9. <https://doi.org/10.3390/ijerph17249450>
- Sunarmi, A., Haksari, E. L., & Fitriahadi, E. (2022). *Childbirth counseling by WhatsApp group to reduce the anxiety of primigravida. International Journal of Health & Medical Sciences*, 5(3), 193–200. <https://doi.org/10.21744/ijhms.v5n3.1905>
- Tang, X., Lu, Z., Hu, D., & Zhong, X. (2019). *Influencing factors for prenatal Stress, anxiety and depression in early pregnancy among women in Chongqing, China. Journal of Affective Disorders*, 253(March), 292–302. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.05.003>

## Glosarium

### B

**Bipolar** : adalah perubahan suasana hati yang ekstrem antara euforia dan depresi.

---

### D

**Depresi** : adalah perasaan sedih mendalam yang bertahan lama dan memengaruhi aktivitas sehari-hari. Depresi merupakan salah satu istilah penyakit mental yang sering terdengar dan sering dipakai di tengah masyarakat.

---

### O

**OCD** : Adalah gangguan berupa obsesi dan kebiasaan berulang yang sulit dikendalikan, yang dapat muncul di periode awal masa kehamilan, dan meningkat seiring masa kehamilan hingga pasca melahirkan.

---

### S

**Skizofrenia** : Adalah gangguan serius yang memengaruhi cara berpikir, merasakan, dan berperilaku.

# BAB II

## EDUKASI TENTANG PENTINGNYA DUKUNGAN EMOSIONAL SELAMA KEHAMILAN

---

### A. Pendahuluan

---

Kehamilan adalah fase penting dalam kehidupan seorang wanita yang melibatkan perubahan fisik, emosional, dan psikologis yang signifikan. Selama masa ini, dukungan emosional dari pasangan, keluarga, dan lingkungan sosial memiliki peran krusial dalam menjaga kesejahteraan ibu hamil serta perkembangan janin. Salah satu aspek yang sangat berperan dalam menjaga keseimbangan psikologis ibu selama kehamilan adalah dukungan emosional. Dukungan emosional yang cukup dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan ibu, serta mendukung perkembangan janin yang sehat (Cutrona & Russell, 1987). Selanjutnya dukungan emosional yang memadai dapat membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasan, yang sering kali dialami selama kehamilan (Dunkel Schetter & Tanner, 2012).

Stres dan kecemasan yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan bayi, termasuk peningkatan risiko persalinan prematur dan berat badan lahir rendah (Lobel & Dunkel-Schetter, 1990). Oleh karena itu, memahami pentingnya dukungan emosional dan bagaimana faktor sosial, budaya, serta psikologis mempengaruhi kesejahteraan ibu hamil menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian (Taylor, 2011).

Dukungan emosional ibu selama hamil dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pasangan, keluarga, teman, serta tenaga medis yang memberikan perawatan selama kehamilan. Studi menunjukkan bahwa ibu hamil yang menerima dukungan emosional yang memadai cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah dan lebih siap dalam menghadapi persalinan (Kusmiyati, 2009). Selain itu, dukungan emosional yang optimal juga dikaitkan dengan peningkatan kualitas hubungan antara ibu dan pasangan serta memberikan dampak positif terhadap perkembangan bayi di masa depan (Sulistiyaningsih, Kasanah, & Sholikhah, 2019). Dukungan emosional juga berperan dalam meningkatkan kesiapan ibu menghadapi persalinan dan masa postpartum. Komunikasi yang baik dengan pasangan dan keluarga, serta keterlibatan tenaga medis dalam memberikan dukungan psikologis, dapat membantu ibu merasa lebih tenang dan siap menghadapi perubahan yang terjadi selama kehamilan (Taylor, 2011).

Sayangnya, tidak semua ibu hamil mendapatkan dukungan emosional yang cukup. Beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman suami dan keluarga mengenai pentingnya dukungan emosional, tekanan sosial, serta kondisi ekonomi, sering kali menjadi penghalang bagi ibu hamil untuk mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan (Zanden, 1985). Oleh karena itu, edukasi mengenai pentingnya dukungan emosional selama kehamilan menjadi aspek krusial yang harus diberikan kepada pasangan, keluarga, serta masyarakat luas. Edukasi mengenai dukungan emosional selama kehamilan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran pasangan dan lingkungan dalam mendukung kesejahteraan mental ibu hamil. Menurut Isnaini (2024), informasi yang tepat mengenai cara memberikan dukungan emosional dapat membantu keluarga dalam memahami kebutuhan psikologis ibu hamil dan memberikan respons yang sesuai. Selain itu, Nugraha (2025) menambahkan bahwa edukasi yang baik dapat mencegah risiko gangguan kesehatan mental selama kehamilan, seperti depresi prenatal dan kecemasan berlebihan. Lebih lanjut, pendekatan yang lebih sistematis dalam memberikan edukasi tentang dukungan emosional bagi ibu hamil sangat diperlukan. Program edukasi ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, penyuluh keluarga, serta komunitas ibu hamil. Salamah (2024) menegaskan bahwa edukasi yang diberikan melalui berbagai media, seperti seminar, kelas prenatal, atau kampanye digital, dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya peran emosional dalam kehamilan. Selain itu, akses yang lebih luas terhadap layanan konseling psikologis juga perlu ditingkatkan untuk memberikan dukungan tambahan bagi ibu yang mengalami kesulitan emosional (Gurumuda, 2024).

Dalam konteks kesehatan masyarakat, edukasi mengenai dukungan emosional selama kehamilan juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ibu dan anak secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Mother & Beyond (2024) menunjukkan bahwa ibu yang mendapatkan dukungan emosional cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan hubungan yang lebih harmonis dengan pasangan serta keluarga. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap kesehatan mental dan fisik ibu serta perkembangan bayi yang lebih optimal. pentingnya dukungan emosional selama kehamilan merupakan langkah fundamental dalam meningkatkan kesejahteraan ibu hamil. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai cara memberikan dukungan emosional, pasangan dan keluarga dapat membantu ibu hamil menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama kehamilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara tenaga kesehatan, komunitas, serta keluarga dalam meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap kesehatan mental ibu hamil demi menciptakan generasi yang lebih sehat dan

sejahtera di masa depan. Dukungan emosional selama kehamilan memainkan peran penting dalam kesejahteraan ibu hamil.

## **B. Faktor yang mempengaruhi Dukungan Emosional.**

---

1. **Lingkungan keluarga dan pasangan:** Lingkungan keluarga dan pasangan memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan emosional ibu hamil. Suami atau pasangan yang mendukung dapat membantu mengurangi stres dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan berbagi tanggung jawab dalam persiapan kehadiran bayi (Lobel & Dunkel-Schetter, 1990). Keluarga yang harmonis dan mendukung juga dapat menciptakan rasa nyaman dan aman bagi ibu hamil, sehingga mengurangi risiko gangguan emosional (Taylor, 2011). Kusmiyati (2009) menyatakan bahwa dukungan dari suami dan keluarga sangat berperan dalam mengurangi kecemasan dan stres pada ibu hamil. Kurangnya dukungan dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan masalah perkembangan anak.
2. **Faktor sosial dan budaya :** Nilai-nilai sosial dan budaya turut memengaruhi bagaimana dukungan emosional diberikan kepada ibu hamil (Dunkel Schetter & Tanner, 2012). Di beberapa budaya, keluarga besar memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada ibu hamil, sedangkan di budaya lain, peran ini lebih banyak dipegang oleh pasangan (Taylor, 2011). Persepsi masyarakat tentang kehamilan dan peran ibu juga dapat menentukan tingkat dukungan yang diterima, baik dalam bentuk dukungan moral maupun bantuan praktis (Lobel & Dunkel-Schetter, 1990). Zanden (1985) mengungkapkan bahwa faktor seperti kondisi ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi tingkat kecemasan ibu hamil. Dukungan emosional yang memadai dapat membantu ibu mengatasi tantangan yang terkait dengan faktor-faktor ini.
3. **Faktor psikologis ibu hamil :** Kondisi psikologis ibu hamil, seperti riwayat gangguan kecemasan atau depresi, dapat mempengaruhi cara ia merespons dukungan yang diberikan (Dunkel Schetter & Tanner, 2012). Ibu yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dan memiliki strategi koping yang baik cenderung lebih mudah menerima dan memanfaatkan dukungan emosional yang ada (Taylor, 2011). Sebaliknya, ibu dengan kecemasan tinggi mungkin memerlukan dukungan lebih intensif dan bimbingan profesional (Lobel & Dunkel-Schetter, 1990). Menurut Pieter (2011), selama kehamilan, ibu mengalami perubahan psikologis seperti labilitas mood, insomnia, dan meningkatnya responsivitas emosi. Perubahan ini dapat mempengaruhi kebutuhan akan dukungan emosional dari lingkungan sekitar..



4. **Pengaruh hormon terhadap emosi ibu hamil** : Perubahan hormon selama kehamilan, seperti peningkatan kadar estrogen dan progesteron, dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang signifikan (Dunkel Schetter & Tanner, 2012). Hormon-hormon ini berperan dalam mengatur emosi, dan fluktuasi kadar hormon dapat menyebabkan ibu hamil merasa lebih sensitif, mudah marah, atau cemas (Taylor, 2011). Oleh karena itu, pemahaman akan perubahan hormonal ini penting agar lingkungan sekitar dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dan empati terhadap kondisi ibu hamil (Lobel & Dunkel-Schetter, 1990). Sulistyaningsih, Kasanah, dan Sholikhah (2019) menjelaskan bahwa kesehatan mental ibu hamil, termasuk adanya depresi atau kecemasan, dapat dipengaruhi oleh dukungan emosional yang diterima. Masalah kesehatan mental selama kehamilan dapat berdampak pada perkembangan kognitif dan emosional anak.

### **C. Manfaat Dukungan Emosional Selama Kehamilan.**

---

1. **Mengurangi stres dan kecemasan** : Dukungan emosional yang kuat dapat membantu ibu hamil mengelola stres dan kecemasan yang mungkin timbul selama kehamilan. Suami yang terlibat aktif dalam kehamilan dapat membantu istri dengan mencari informasi yang relevan mengenai kondisi kehamilan, termasuk nutrisi yang tepat, persiapan persalinan, hingga manajemen nyeri selama melahirkan (Dunkel Schetter & Tanner, 2012). Kusmiyati (2009), dukungan emosional dari pasangan, keluarga, dan lingkungan sosial dapat membantu ibu hamil merasa lebih tenang dan nyaman dalam menghadapi perubahan selama kehamilan.
2. **Meningkatkan kesejahteraan emosional ibu hamil**; Lingkungan yang penuh perhatian dan kasih sayang dapat membantu ibu hamil menjalani proses kehamilan dengan lebih bahagia dan percaya diri. (Taylor, 2011). Pieter (2011) menyatakan bahwa ibu yang mendapatkan dukungan emosional yang cukup cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik, sehingga mengurangi risiko depresi prenatal.
3. **Menjaga kesehatan fisik ibu dan janin**; Dukungan emosional yang memadai dapat mendorong ibu hamil untuk menjaga kesehatan fisik, seperti menjaga pola makan dan rutin memeriksakan kehamilan, yang berdampak positif pada kesehatan janin. (Lobel & Dunkel-Schetter, 1990). Sulistyaningsih, Kasanah, dan Sholikhah (2019) menjelaskan bahwa stres yang rendah dan suasana hati yang stabil pada ibu hamil berkontribusi pada perkembangan janin yang lebih sehat.
4. **Membantu persiapan persalinan dan peran sebagai orang tua**; Dukungan dari pasangan dan keluarga dapat meningkatkan kesiapan ibu dalam menghadapi

persalinan dan peran baru sebagai orang tua. Taylor, 2011). Dengan dukungan emosional yang cukup, ibu hamil lebih percaya diri dalam menghadapi proses persalinan dan menjadi orang tua. Zanden (1985) mengungkapkan bahwa dukungan emosional yang baik dapat mempererat hubungan antara ibu dengan pasangan serta anggota keluarga lainnya.

#### **D. Bentuk Dukungan Emosional Ibu selama hamil**

---

**Bentuk dukungan emosional ibu selama hamil adalah sebagai berikut :**

1. Dukungan dari pasangan : Suami yang terlibat aktif dalam kehamilan dapat membantu istri dengan mencari informasi yang relevan mengenai kondisi kehamilan, termasuk nutrisi yang tepat, persiapan persalinan, hingga manajemen nyeri selama melahirkan (Dunkel Schetter & Tanner, 2012).
2. Peran keluarga dan teman dekat : Lingkungan yang penuh perhatian dan kasih sayang dapat membantu ibu hamil menjalani proses kehamilan dengan lebih bahagia dan percaya diri (Taylor, 2011).
3. Konseling dan dukungan profesional: Konseling psikologis adalah alat yang kuat dan bermanfaat untuk membantu ibu hamil mengatasi berbagai tantangan emosional dan mental selama kehamilan (Lobel & Dunkel-Schetter, 1990).
4. Kelompok dukungan ibu hamil: Bergabung dengan kelompok dukungan dapat menjadi wadah bagi ibu hamil untuk saling tukar pikiran dan bercerita, sehingga merasa lebih positif tentang pengalaman melahirkan secara keseluruhan (Dunkel Schetter & Tanner, 2012).
5. Peran tenaga medis dalam memberikan dukungan emosional: Tenaga medis yang memberikan konseling dan edukasi selama kehamilan dapat membantu ibu hamil mengelola stres dan kecemasan, serta mempersiapkan diri untuk persalinan (Taylor, 2011).

**Selain yang dibahas diatas Dukungan emosional bagi ibu hamil dapat berbentuk berbagai aspek, antara lain:**

1. Dukungan Verbal: Menurut Cutrona dan Russell (1987), ungkapan kasih sayang, dorongan semangat, dan kata-kata yang menenangkan dari pasangan dan keluarga dapat membantu ibu hamil merasa lebih dihargai dan didukung.
2. Kehadiran Fisik: Menurut Sarafino (2002), kehadiran suami atau keluarga dalam berbagai momen penting selama kehamilan dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi ibu hamil.
3. Bantuan dalam Aktivitas Sehari-hari: Lazarus dan Folkman (1984) menjelaskan bahwa dukungan dalam bentuk bantuan fisik, seperti membantu pekerjaan

rumah tangga atau menemani ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan, dapat mengurangi beban dan stres yang dialami.

4. Dukungan Sosial: Menurut House (1981), interaksi sosial yang positif, seperti bergabung dalam komunitas ibu hamil atau berbagi pengalaman dengan ibu lainnya, dapat meningkatkan kesejahteraan emosional.

#### **E. Strategi Meningkatkan Dukungan Emosional Selama hamil**

---

**Untuk meningkatkan dukungan emosional bagi ibu hamil, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:**

1. Menciptakan Lingkungan Positif: Menurut Isnaini (2024), menciptakan lingkungan yang positif di rumah dan di sekitar ibu hamil dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan.
2. Mendengarkan dengan Empati: Nugraha (2025) menyatakan bahwa menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi dapat memberikan rasa nyaman dan dukungan bagi ibu hamil.
3. Memberikan Pujian dan Apresiasi: Salamah (2024) menekankan bahwa menghargai usaha dan peran ibu hamil dalam menjaga kehamilan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan emosional.
4. Mendampingi dalam Aktivitas Sehari-hari: Menurut Plaza Medis (2024), kehadiran suami atau anggota keluarga dalam aktivitas sehari-hari atau saat pemeriksaan kehamilan dapat memberikan rasa aman dan dukungan emosional.
5. Menyediakan Waktu Istirahat: Mother & Beyond (2024) menjelaskan bahwa membantu ibu hamil dengan pekerjaan rumah tangga atau tanggung jawab lainnya dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk beristirahat dengan cukup.
6. Mengikuti Program Dukungan Kelompok: Nugraha (2025) juga menambahkan bahwa bergabung dalam kelompok dukungan ibu hamil memungkinkan berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari sesama.
7. Menyediakan Akses ke Konseling Psikologis: Menurut Gurumuda (2024), menyediakan akses mudah dan terjangkau ke layanan konseling psikologis dapat membantu ibu hamil mengatasi tantangan emosional.

**Selain diatas strategi untuk meningkatkan dukungan emosional selama hamil menurut Dunkel Schetter & Tanner, 2012 adalah sebagai berikut:**

1. Komunikasi efektif dengan pasangan dan keluarga Komunikasi yang terbuka dan jujur antara ibu hamil dengan pasangan dan keluarga dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan yang diberikan;

2. Membangun jaringan sosial yang mendukungBergabung dengan kelompok dukungan atau komunitas ibu hamil dapat memberikan rasa kebersamaan dan saling berbagi pengalaman ;
3. Mengelola stres dan emosi selama kehamilanMenerapkan teknik relaksasi, seperti meditasi atau yoga, dapat membantu ibu hamil mengelola stres dan emosi ;
4. Pendidikan prenatal dan persiapan mental menjelang persalinanMengikuti kelas prenatal atau konseling dapat membantu ibu hamil mempersiapkan diri secara mental untuk persalinan dan peran sebagai orang tua .

## **F. Penutup**

---

Dukungan emosional selama kehamilan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan mental dan fisik ibu hamil (Dunkel Schetter & Tanner, 2012). Dengan lingkungan yang penuh perhatian dan kasih sayang, ibu hamil dapat menjalani proses kehamilan dengan lebih bahagia dan percaya diri (Lobel & Dunkel-Schetter, 1990). Penting bagi pasangan, keluarga, dan tenaga medis untuk memberikan dukungan yang komprehensif (Taylor, 2011). Selain itu, ibu hamil disarankan untuk aktif membangun jaringan sosial yang mendukung dan mencari bantuan profesional jika diperlukan (Dunkel Schetter & Tanner, 2012).

## Referensi

- Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*, 98(2), 310-357. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.98.2.310>
- Cutrona, C. E., & Russell, D. W. (1987). The provisions of social relationships and adaptation to stress. *Advances in Personal Relationships*, 1, 37-67.
- Dunkel Schetter, C., & Tanner, L. (2012). Anxiety, depression and stress in pregnancy: Implications for mothers, children, research, and practice. *Current Opinion in Psychiatry*, 25(2), 141-148. <https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e3283503680>
- Gurumuda. (2024). Akses layanan konseling psikologis bagi ibu hamil. Diakses dari <https://www.gurumuda.com/konseling-psikologis-ibu-hamil>
- Harahap, R. A., Rochadi, R. K., & Sarumpae, S. (2018). Pengaruh aktivitas fisik terhadap kejadian hipertensi pada laki-laki dewasa awal (18-40 tahun) di wilayah Puskesmas Bromo Medan tahun 2017. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 1(2), 68-73. <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v1i2.951>
- House, J. S. (1981). *Work stress and social support*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Isnaini, H. (2024). Stres dan kesehatan mental ibu hamil: Strategi mengelola kesehatan emosional. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/isnainihanifa114307/66f42038ed641521262131b2/stess-dan-kesehatan-mental-ibu-hamil-strategi-mengelola-kesehatan-emosional>
- Kusmiyati. (2009). Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan ibu hamil menghadapi proses persalinan. Diakses dari <https://jurnal.unigal.ac.id/mj/article/download/6821/4415>
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. New York: Springer.
- Lobel, M., & Dunkel-Schetter, C. (1990). Conceptualizing stress to study effects on pregnancy. *Psychology of Women Quarterly*, 14(4), 389-413. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1990.tb00029.x>
- Mother & Beyond. (2024). 5 contoh dukungan emosional bagi ibu hamil. Lakukan ini, Dads!. Diakses dari <https://motherandbeyond.id/read/25835/5-contoh-dukkungan-emosional-bagi-ibu-hamil-lakukan-ini-dads>
- Nugraha, R. (2025). Kesehatan mental ibu: Tantangan, faktor risiko, dan strategi dukungan holistik. Diakses dari <https://infodong.net/kesehatan-mental-ibu->

- Salamah, N. (2024). Kesehatan mental ibu: Tantangan, penyebab, dan strategi penanganan yang komprehensif. Diakses dari <https://infodong.net/kesehatan-mental-ibu-tantangan-penyebab-dan-strategi-penanganan-yang-komprehensif/>
- Sulistiyaningsih, W., Kasanah, N., & Sholikhah, M. (2019). Dukungan emosional dan kesehatan mental ibu hamil. *Jurnal Psikologi Kesehatan*, 7(2), 145-159.
- Taylor, S. E. (2011). Social support: A review. *Oxford Handbook of Health Psychology*. Oxford University Press.
- WHO. (2018). Monitoring progress on universal health coverage and the health-related Sustainable Development Goals in the South-East Asia Region 2018.
- WHO. (2020). Mental health and psychosocial well-being during pregnancy. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240003925>
- Zanden, J. W. (1985). Human development. New York: McGraw-Hill.

## Glosarium

- **Dukungan Emosional:** Bentuk perhatian, kasih sayang, dan bantuan psikologis yang diberikan kepada ibu hamil untuk menjaga kesejahteraan mental dan emosionalnya.
- **Kelompok Dukungan:** Komunitas atau forum tempat ibu hamil dapat berbagi pengalaman, mendapatkan informasi, dan menerima dukungan dari sesama ibu hamil atau profesional.
- **Kecemasan:** Perasaan khawatir atau takut berlebihan yang sering dialami ibu hamil terkait kehamilan, persalinan, atau peran sebagai orang tua.
- **Kesejahteraan Ibu Hamil:** Kondisi kesehatan fisik, mental, dan emosional ibu selama kehamilan yang dipengaruhi oleh dukungan sosial dan lingkungan.
- **Komunikasi Efektif:** Interaksi yang terbuka, jelas, dan jujur antara ibu hamil dengan pasangan, keluarga, atau tenaga medis untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan.
- **Konseling Psikologis:** Proses bantuan profesional yang diberikan oleh psikolog atau konselor untuk membantu ibu hamil mengatasi masalah emosional atau mental.
- **Nilai Sosial dan Budaya:** Norma, kebiasaan, dan tradisi yang mempengaruhi cara dukungan emosional diberikan kepada ibu hamil dalam suatu komunitas atau masyarakat.
- **Peran Pasangan:** Keterlibatan suami atau pasangan dalam memberikan dukungan emosional, fisik, dan mental kepada ibu hamil selama masa kehamilan dan persalinan.
- **Stres:** Reaksi fisik dan emosional yang muncul akibat tekanan atau tantangan, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan janin jika tidak dikelola dengan baik.
- **Strategi Koping:** Cara atau mekanisme yang digunakan individu untuk menghadapi stres, kecemasan, atau tekanan emosional.
- **Dukungan Emosional:** Bantuan yang diberikan dalam bentuk perhatian, kasih sayang, dan komunikasi yang positif untuk membantu individu mengelola perasaan dan stres.
- **Kesejahteraan Emosional:** Kondisi di mana seseorang merasa tenang, bahagia, dan mampu mengelola emosi dengan baik.
- **Konseling Psikologis:** Proses interaksi antara individu dengan profesional psikologi untuk membahas dan mengatasi permasalahan emosional atau mental.

- **Kelompok Dukungan:** Sekumpulan individu dengan pengalaman serupa yang berkumpul untuk berbagi cerita dan memberikan dukungan satu sama lain.
- **Stres Kehamilan:** Tekanan emosional yang dialami ibu hamil akibat perubahan fisik, psikologis, dan sosial selama masa kehamilan.
- **Strategi Koping:** Cara yang digunakan individu untuk menghadapi dan mengatasi stres atau masalah emosional.



# BAB III

## AKTIVITAS FISIK YANG MENDUKUNG KESEIMBANGAN MENTAL IBU HAMIL

---

### A. Pendahuluan

---

Kesehatan mental merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di seluruh dunia, dan dianggap sebagai aspek penting dari kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi juga mencakup pengalaman ibu hamil terhadap perubahan kesehatan fisik dan mental selama kehamilan dan setelah melahirkan. Masa kehamilan merupakan tahap transisi bagi wanita menjadi ibu ketika emosi negatif dan perubahan sosial yang dialami oleh wanita dapat berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan ibu baru dan bayi yang baru lahir. Periode dari pembuahan hingga usia dua tahun merupakan tahap kritis ketika dukungan positif yang diterima oleh ibu berdampak positif pada bayi yang baru lahir dan memberikan awal terbaik bagi kehidupan mereka (Sah et al., 2024).

Perempuan sangat rentan terhadap berbagai jenis dan tingkat masalah kesehatan mental selama kehamilan, dengan depresi, stres, dan kecemasan menjadi yang paling umum dan sering terjadi secara bersamaan. Prevalensi depresi prenatal dilaporkan berkisar antara 7 dan 37,1%, dan depresi tersebut terkait erat dengan konsekuensi kesehatan ibu dan janin yang merugikan. Demikian pula, kecemasan antenatal, dengan prevalensi global 15-20% dan tingkat yang lebih tinggi dilaporkan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, tampaknya terkait dengan kelahiran prematur dan penurunan tingkat menyusui. Mengingat hubungan antara kondisi mental ibu yang berubah dengan hasil yang merugikan, merawat kesehatan mental ibu hamil muncul sebagai prioritas tinggi (Song et al., 2024).

Perubahan fisik terjadi pada ibu hamil, yang dapat menyebabkan komplikasi pada kehamilan atau persalinan. Kehamilan mengubah semua sistem dalam tubuh untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan janin yang memadai, seperti penambahan berat badan yang berlebihan, pergerakan struktur tulang, dan perubahan hormonal. Perubahan lainnya adalah perubahan adaptasi wanita terhadap kondisi metabolisme, yang meningkatkan resistensi insulin. Jika tidak dipantau dan diobati, dampak fisik dan mental dapat berdampak negatif. Misalnya, obesitas dapat menyebabkan diabetes gestasional, hipertensi, dan depresi, yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan (Rodrigues-Denize et al., 2024).

Negara Amerika Serikat, 12 hingga 25% ibu hamil melaporkan mengalami kelebihan berat badan dan sekitar 25% melaporkan mengalami obesitas. Gejala depresi meningkat hingga 25% lebih banyak selama kehamilan dan penurunan kenaikan berat badan selama kehamilan terbukti juga dapat meringankan gejala-gejala ini. Sebagian besar gejala selama kehamilan dapat diatur, dicegah, dan dikurangi secara signifikan dengan aktivitas fisik, misalnya, olahraga terbukti dapat menurunkan risiko kematian karena sebab apa pun hingga 31%, mengurangi diabetes gestasional hingga 30%, dan menurunkan komplikasi kardiovaskular hingga 30% (Rodrigues-Denize et al., 2024).

Aktivitas fisik mengacu pada aktivitas tubuh apa pun yang melibatkan pergerakan otot rangka yang mengakibatkan pengeluaran energi, dan mencakup serangkaian jenis aktivitas termasuk olahraga, rekreasi, dan aktivitas keluarga dan profesional. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia memperbarui pedoman untuk perilaku sedentary dan aktivitas fisik pada tahun 2020, yang mendorong ibu hamil untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik intensitas sedang (150 menit/minggu) dalam pekerjaan rumah tangga dan kehidupan sehari-hari, yang terkait dengan berbagai manfaat kesehatan, dan manfaat ini dapat diilustrasikan oleh perubahan dalam proses kardiovaskular dan metabolisme. Lebih jauh, menarik untuk dicatat bahwa aktivitas aktivitas fisik berkontribusi untuk memperbaiki kondisi fisik ibu hamil dan mengoptimalkan pola tidur, suasana hati, dan kesehatan, sehingga mencegah komplikasi terkait kehamilan, dan meningkatkan kapasitas kerja (Song et al., 2024).

Olahraga dan kehamilan secara keseluruhan memiliki hubungan positif dan berkontribusi pada peningkatan manfaat kesehatan bagi ibu hamil. Secara keseluruhan, berjalan atau berlari ditemukan memiliki penurunan paling signifikan pada gejala kehamilan yang muncul secara khusus karena olahraga. Meskipun demikian, berbagai latihan seperti yoga, latihan air, dan menari ditemukan membantu wanita hamil dengan kesehatan mental, sementara latihan aerobik dan latihan ketahanan lebih membantu wanita dengan kesehatan fisik (Rodrigues-Denize et al., 2024).

## **B. Prenatal Yoga**

---

Prenatal Yoga adalah salah satu jenis pengobatan tradisional Tiongkok yang populer dalam beberapa tahun terakhir di kalangan ibu hamil. Yoga adalah pendekatan komprehensif yang berfokus pada ajaran mental, fisik, spiritual, emosional, dan etika. Yoga memengaruhi pelepasan  $\beta$ -endorfin dan neurotransmitter, yang mengakibatkan perubahan fisiologis dan neurofisiologis.

Yoga memberikan relaksasi dengan memengaruhi pelepasan dopamin, serotonin, dan kortisol, yang bertanggung jawab atas perubahan emosional. Yoga mengurangi gejala psikologis yang umum terjadi selama kehamilan, seperti stres, kecemasan, depresi, dan kemarahan. Yoga membantu ibu hamil mengatasi gejala fisiologis, seperti masalah pada sistem peredaran darah, sistem kemih, sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem muskuloskeletal; kelebihan berat badan, kelelahan, masalah tidur, dan gula darah tinggi. Ibu hamil yang melakukan yoga memiliki otot perineum dan tulang belakang yang lebih kuat, serta persalinan yang lebih singkat dan tidak terlalu menyakitkan. Penelitian menunjukkan bahwa yoga selama kehamilan membantu mengurangi stres dan depresi serta meningkatkan hasil kehamilan (Simsek Sahin & Can Gürkan, 2023).

Yoga adalah latihan peregangan dan pembentukan kekuatan tanpa menggunakan alat atau mesin. Yoga biasanya dilakukan selama satu jam sehari selama sekitar tiga kali seminggu. Setiap sesi dilakukan satu hingga tiga kali seminggu selama 50 hingga 60 menit. Manfaat terbesar diperoleh jika dilakukan selama 10 hingga 12 minggu berturut-turut atau lebih. Bagi ibu hamil, pedoman menyarankan untuk tidak melakukan gerakan yoga yang menyebabkan otot perut menegang. Selain itu, ibu hamil harus menghindari posisi yang mengharuskan berbaring telentang atau posisi membungkuk, inversi (misalnya handstand), dan posisi lanjutan yang dapat membahayakan tubuh dan janin. Posisi yoga, seperti pose segitiga, pose sudut terikat, pose kucing, pose prajurit, lipatan ke depan, jongkok, dan pose pembalasan, harus dimodifikasi selama kehamilan. Misalnya, pose istirahat terakhir harus dilakukan di permukaan tempat kepala dan punggung dapat ditinggikan untuk mengurangi potensi tekanan pada vena utama. Yoga dapat menjadi cara yang aman untuk berolahraga dengan menggunakan modifikasi untuk membantu meringankan komplikasi kehamilan (Rodrigues-Denize et al., 2024).

Sekitar 7% wanita berlatih yoga selama kehamilan mereka, meskipun yoga telah terbukti memengaruhi aspek mental seperti kecemasan, depresi, kemarahan, dan stres secara positif. Yoga mengurangi gejala depresi dan kecemasan pada wanita hamil yang mempraktikkannya, serta memediasi beberapa komplikasi fisik dan fisiologis yang mungkin dialami wanita hamil, seperti nyeri punggung bawah, nyeri kaki, dan nyeri panggul. Latihan yoga dapat digunakan untuk mengelola gejala kehamilan. Misalnya, penggunaan peregangan dan relaksasi menyebabkan penurunan nyeri tubuh bagian bawah yang signifikan. Selain itu, latihan otot panggul secara teratur melalui yoga postural dapat meningkatkan tonus otot panggul yang membantu mengurangi persalinan aktif dan nyeri ibu. Lebih jauh, yoga meningkatkan aktivitas parasimpatis dan mengurangi aktivitas simpatis pada

trimester ketiga, yang secara berurutan menurunkan hipertensi dan preeklamsia (Rodrigues-Denize et al., 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa yoga prenatal dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan fisik dengan meningkatkan fleksibilitas, mengurangi keparahan ketidaknyamanan umum, dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular secara keseluruhan. Selain itu, aspek kesadaran dan relaksasi yoga telah dikaitkan dengan penurunan tingkat stres dan kecemasan di antara ibu hamil. Sun, Hung et al (2010) melakukan penelitian yang melibatkan 88 wanita hamil, dengan 45 orang berpartisipasi dalam intervensi dan menunjukkan bahwa program yoga prenatal selama 12-14 minggu menghasilkan pengurangan ketidaknyamanan dan peningkatan efikasi diri untuk melahirkan (Liang, 2024).

Rekomendasi untuk melakukan Yoga Prenatal selama kehamilan, dengan penekanan khusus pada trimester kedua, sejalan dengan prinsip keselamatan dan kemampuan beradaptasi. Pada trimester awal, disarankan untuk memperkenalkan latihan baru dengan hati-hati karena ini adalah tahap utama perkembangan janin dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Saat kehamilan berlanjut ke trimester kedua, Yoga Prenatal menjadi praktik yang berharga, menawarkan fleksibilitas dan pengurangan stres. Namun, penting untuk mengubah pose dan gerakan, menghindari yang dapat membebani perut yang membesar atau mengganggu keseimbangan. Pada trimester ketiga, penekanan bergeser ke gerakan lembut, pose yang dimodifikasi, dan praktik yang meningkatkan relaksasi. Pose yang melibatkan berbaring telentang harus dilakukan dengan hati-hati karena potensi kompresi vena cava. Memang, panduan individual dari penyedia layanan kesehatan memastikan pendekatan Yoga Prenatal yang aman dan disesuaikan selama setiap tahap kehamilan (Liang, 2024). Melakukan yoga selama kehamilan mengurangi angka *caesarean Section* saat persalinan, mengurangi rasa tidak nyaman, dan mendorong kelahiran spontan melalui vagina pada ibu hamil tunggal primipara (Kuder et al., 2024).

### **C. Tari (*Dance*)**

---

Tari adalah ekspresi diri melalui gerakan tubuh. Tari semakin dikenal dalam perawatan kesehatan sebagai bentuk aktivitas fisik karena berbagai manfaatnya. Tari terbukti membantu ibu hamil menciptakan perasaan dan emosi positif terkait kehamilan mereka. Selain itu, seperti yoga, tari atau terapi tari terbukti dapat mengurangi depresi dan meningkatkan kadar energi pada ibu hamil; efek ini juga dapat mengurangi kecemasan selama kehamilan. Tari juga terbukti membantu

menjaga tekanan darah dengan menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik (turun 11%) (Alpert, 2011).

Studi lain oleh Santos dan rekan-rekannya (2005) mengamati peningkatan kebugaran kardiorespirasi sebesar 18% dalam 12 minggu latihan tiga kali seminggu. Selain itu, ada penurunan rasa sakit yang signifikan dibandingkan dengan wanita yang tidak menari saat persalinan karena penurunan aktivasi dasar panggul yang menyebabkan gangguan dari rasa sakit yang terkait dengan persalinan. Beberapa gerakan yang dapat membantu mengatasi nyeri persalinan termasuk gerakan tarian melingkar panggul dan pinggang, kemiringan panggul, dan menari ke kiri dan kanan. Sebagian besar wanita hamil menyatakan menari membantu mereka merasa lebih terkendali dan tidak takut menghadapi pengalaman persalinan. Pedoman menari dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi wanita hamil untuk berolahraga. Gerakan melompat harus dihindari. Selain itu, menyediakan kursi di sekitar untuk membantu menjaga keseimbangan dan menghindari risiko jatuh adalah pedoman lain yang dapat mendorong menari yang aman (Gönenç & Dikmen, 2020).

#### **D. Latihan Ketahanan (*Resistance Training*)**

---

Latihan Ketahanan adalah jenis latihan ketiga yang paling umum dilakukan oleh wanita saat hamil dan merupakan bentuk latihan yang meningkatkan kekuatan otot menggunakan beban atau pita resistensi. Hanya 10% wanita hamil yang melaporkan melakukan jenis latihan ini karena sifatnya yang ekstrem. Dengan latihan ini, wanita melaporkan peningkatan motivasi, perubahan suasana hati yang lebih baik, dan berkurangnya stres selama kehamilan. Penelitian lebih lanjut berfokus pada manfaat fisik dari latihan ini. Manfaatnya termasuk penurunan mual, kelelahan, dan sakit kepala, dan kemungkinan penurunan tekanan darah. Hasil yang lebih baik termasuk penurunan angka preeklamsia sebesar 24% dan penurunan diabetes gestasional sebesar 59%. Satu penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak wanita melahirkan secara alami tanpa perlu pengobatan, sementara dua penelitian lain tidak melihat perbedaan yang signifikan dalam cara persalinan. Sebuah penelitian lain juga mengonfirmasi tidak ada perbedaan yang signifikan antara komplikasi selama persalinan saat menggunakan latihan ketahanan (Rodrigues-Denize et al., 2024).

Latihan ketahanan dapat meningkatkan harga diri, citra diri, kepercayaan diri, dan rasa kendali selama kehamilan dengan meningkatkan kekuatan fisik dan kemampuan untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri. Peningkatan harga diri dan kepercayaan diri kemudian dikaitkan dengan berkurangnya kejadian kecemasan dan depresi dan peningkatan rasa kendali atas

perubahan fisik kehamilan, yang juga dikaitkan dengan peningkatan kesehatan mental secara keseluruhan. Faktanya, latihan ketahanan yang dikombinasikan dengan aktivitas fisik teratur telah terbukti mengurangi kejadian dan tingkat keparahan depresi selama kehamilan. Semua peningkatan ini terkait dengan peningkatan kualitas hidup, yang memiliki implikasi signifikan bagi kesehatan fisik dan mental selama kehamilan. Mengingat meningkatnya prevalensi masalah kesehatan mental selama dan setelah kehamilan, implikasi latihan kekuatan untuk membantu ibu baru dan calon ibu sangat besar (Duchette et al., 2024).

Pedoman latihan ketahanan harus diikuti dengan ketat karena jenis latihan ini dapat menyebabkan cedera. Salah satu pedoman utama adalah melatih otot inti untuk meregang alih-alih berkontraksi, mirip dengan yoga. Sebagian besar sesi latihan dilakukan selama 60 menit tiga kali seminggu. Latihan setiap hari yang tidak berurutan membantu meningkatkan pemulihan neuromuskular. Selain itu, seiring dengan perkembangan kehamilan, modifikasi pada latihan ketahanan juga harus dilakukan. Selama trimester pertama, tidak ada modifikasi yang perlu dilakukan, kecuali menggunakan bentuk tubuh yang tepat dan menghindari gerakan balistik. Pada trimester kedua dan ketiga, penggunaan bantal dan handuk dapat membantu gerakan tertentu. Posisi terlentang harus dihindari, yang dapat menghalangi aliran balik vena dari rahim yang mengakibatkan kekurangan oksigen. Selain itu, dua hingga tiga set dengan 12 hingga 15 repetisi per set untuk setiap latihan harus dilakukan, dengan istirahat selama dua hingga empat menit di antara setiap set. Idennya adalah melakukan repetisi dalam jumlah banyak dengan jumlah beban yang rendah. Wanita hamil dapat menggunakan beban bebas yang sebaiknya tidak lebih dari lima pon. Selain itu, lunge, deadlift kaki diam, lompat, dan squat harus dihindari. Selain itu, sebaiknya berolahraga setelah makan untuk menghindari hipoglikemia (Rodrigues-Denize et al., 2024).

### **E. Berjalan (*Walking*)**

---

Berjalan adalah proses yang berirama dan dinamis yang menggunakan kelompok otot besar dari tungkai, tungkai-korset, dan badan. Sekitar 85% wanita hamil yang berolahraga melaporkan bahwa berjalan adalah pilihan olahraga mereka [33]. Selain itu, berjalan juga dianggap sebagai aktivitas fisik yang paling aman dan termudah bagi wanita hamil. Ada korelasi negatif secara statistik antara depresi dan berjalan setiap hari, dan seiring dengan meningkatnya jumlah berjalan setiap hari, tingkat depresi dan kecemasan menurun. Hal ini penting karena penurunan gejala depresi telah ditemukan dapat mengurangi gejala kecemasan (Petrovic, Danica, Milan Perovic & Pantic, 2016).

Manfaat kesehatan lainnya termasuk penurunan kadar glukosa sebesar 4–21% setelah berjalan, sehingga menyebabkan penurunan risiko diabetes gestasional sebesar 20% dan penurunan risiko preeklamsia sebesar 33%. Penelitian lain menemukan penurunan risiko kenaikan berat badan di luar batas normal sebesar 29 hingga 44% pada wanita hamil yang berjalan. Selain itu, berjalan terbukti dapat meredakan nyeri yang terkait dengan persalinan aktif. Terdapat pula penurunan usia kehamilan saat melahirkan; tetapi masih belum jelas hubungan antara berjalan dan kelahiran prematur, yang berarti berjalan tidak dapat dikaitkan dengan tanggal persalinan. Angka persalinan per vaginam dengan bantuan meningkat, tetapi hubungan antara berjalan dan risiko persalinan sesar tidak ditemukan. Selain itu, berjalan setengah jam sehari menyebabkan penurunan berat badan kehamilan sebesar 0,551 pon. Meskipun hubungan yang signifikan tidak dapat ditentukan dalam usia kehamilan, berjalan juga dapat membantu mengurangi retensi berat badan pascapersalinan (Connolly et al., 2019).

Pedoman berjalan kaki merupakan salah satu yang paling mudah dipatuhi karena berjalan kaki tidak memerlukan peralatan apa pun. Diperlukan total 10.000 langkah untuk meningkatkan manfaatnya. Sebuah studi tentang jumlah langkah juga dibuat oleh untuk menentukan hasil positif sekitar 11.060 langkah setiap hari. Pedoman juga diberikan untuk berolahraga di atas treadmill guna menghindari medan yang tidak konsisten serta menciptakan lingkungan yang lebih aman; kecuali bahwa bukit-bukit di atas treadmill harus dihindari dengan pemanasan pada kecepatan yang lebih rendah. Saran lain adalah untuk fokus pada kualitas latihan seseorang, bukan pada jarak jalan kaki seseorang, yang dapat berkontribusi pada perasaan positif yang dicapai. Dengan lebih sedikit berfokus pada langkah dan lebih pada waktu, studi lain menetapkan bahwa rata-rata 25 hingga 40 menit sehari dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Terlepas dari jumlah langkah, waktu, atau kecepatan, semua jenis jalan kaki ditemukan bermanfaat bagi wanita hamil (Connolly et al., 2019).

## **F. Berlari (*Running*)**

---

Berlari dapat menjadi aktivitas yang intens dan menahan beban; oleh karena itu, berlari biasanya dianggap sebagai latihan fisik sekunder bagi wanita hamil dibandingkan berjalan. Peningkatan kesehatan mental, serta dukungan emosional, dikaitkan dengan peningkatan aktivitas berlari di kalangan wanita hamil. Wanita hamil yang berlari cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang perubahan yang terjadi pada tubuh mereka selama kehamilan, yang dapat membantu mereka terhubung dengan kehamilan mereka. Selain itu, wanita yang

berlari selama kehamilan juga cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk melaporkan depresi pascapersalinan (Gordon, 2019).

Berlari menyebabkan peningkatan penyerapan oksigen, yang dapat menyebabkan peningkatan sirkulasi dan aliran darah ke janin dan tubuh. Meskipun demikian, penurunan konsumsi oksigen ditemukan pada wanita yang berlari pada usia kehamilan 32 minggu dibandingkan pada usia kehamilan 20 minggu. Selain itu, penelitian lain menyimpulkan bahwa wanita yang tidak pernah berlari selama kehamilan mengalami kenaikan berat badan rata-rata 5 pon dibandingkan dengan wanita yang berlari. Selain itu, risiko kenaikan berat badan di luar kehamilan menurun sebesar 29–44%, jumlah yang direkomendasikan untuk wanita hamil yang berlari juga ditentukan. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa manfaat berlari saat hamil, seperti penurunan kadar trigliserida dan detak jantung istirahat, tampak jelas. Berlari juga menciptakan otot dasar panggul yang lebih kuat, sehingga mungkin berkontribusi pada proses persalinan yang lebih baik (Rodrigues-Denize et al., 2024).

Pedoman lari harus dibuat untuk membantu mengurangi kelelahan detak jantung janin. Oleh karena itu, menjaga keteraturan jarak selama kehamilan, rupanya berlari untuk mendapatkan jarak, dapat bermanfaat bagi janin dan ibu. Selain itu, wanita hamil harus fokus pada kualitas lari dan perasaan terkait dengannya. Selain itu, berlari selama 30 menit hingga 60 menit selama dua hingga tujuh hari seminggu terbukti memberikan manfaat terbesar selama kehamilan. Pedoman yang dapat membantu wanita mengurangi risiko jatuh dengan berlari di atas treadmill dan mengenakan sepatu lari yang tepat. Telapak kaki wanita hamil cenderung berubah di lengkungan serta menjadi rata atau melebar selama kehamilan, jadi penggunaan sepatu yang tepat dapat membantu mengurangi cedera yang dapat dihindari. Terakhir, wanita hamil harus berhenti berlari sekitar minggu ke-27 hingga ke-28. Minggu-minggu ini cenderung menjadi waktu ketika sebagian besar wanita hamil merasakan tekanan panggul karena berlari. Mematuhi pedoman dapat membantu wanita hamil menikmati lari sambil juga menghindari risiko bagi janin dan tubuh (Rodrigues-Denize et al., 2024).

## **G. Senam Hamil (*pregnancy exercises*)**

---

Salah satu tindakan nonfarmakologis dalam rangka meningkatkan kontraksi rahim antara lain adalah senam hamil. Senam hamil merupakan salah satu aktivitas fisik yang dapat dilakukan ibu selama masa kehamilan karena gerakan-gerakan dalam senam hamil cenderung ringan dan mengandung efek relaksasi yang membantu menstabilkan kecemasan dan mengurangi rasa takut. Manfaat lainnya



bagi ibu hamil adalah mendapatkan informasi tentang persalinan sehingga ibu hamil memiliki pengetahuan yang baik dan akan mempersiapkan diri menghadapi persalinan (Susanti et al., 2024).

Senam hamil merupakan salah satu bentuk perawatan komplementer, di beberapa masyarakat, kebidanan telah menjadi bagian penting dari praktik kebidanan. Perempuan, khususnya ibu hamil, merupakan konsumen pengobatan komplementer yang paling banyak. Salah satu alasan mengapa perawatan komplementer menjadi pilihan klien adalah ketidakpuasan terhadap pengobatan konvensional dan mengabaikan pendekatan holistik, serta kekhawatiran tentang efek samping obat (Susanti et al., 2024).

Senam hamil merupakan gerakan-gerakan tubuh yang berupa latihan-latihan dengan aturan, sistematika, dan prinsip-prinsip kegiatan tertentu yang disesuaikan dengan kondisi ibu hamil. Penelitian lebih lanjut menyebutkan bahwa gerakan-gerakan senam hamil mengandung efek relaksasi yang dapat menstabilkan emosi ibu hamil. Melalui senam hamil, ibu hamil akan diajarkan cara-cara untuk mengurangi rasa cemas dan mengurangi rasa takut melalui relaksasi fisik dan mental, serta memperoleh informasi yang mempersiapkan dirinya untuk mengalami apa yang akan terjadi pada saat persalinan dan melahirkan. Oleh karena itu, pemberian perawatan komplementer berupa olahraga selama kehamilan dapat memberikan dampak penurunan tingkat kecemasan (Susanti et al., 2024).

Senam hamil dilakukan tidak hanya untuk kebugaran saja, namun untuk menguatkan otot, melenturkan sendi, dan yang terutama melatih konsentrasi agar pikiran dapat teralihkan sehingga dapat melupakan rasa sakit saat melahirkan dan juga menguatkan pernapasan. Senam hamil terbukti dapat membantu memperlancar proses persalinan. Selain itu, rasa sakit saat proses persalinan juga dapat diminimalisir, dengan cara mengatur pernapasan, berkonsentrasi, dan mengalihkan pikiran, sehingga stres saat melahirkan otomatis berkurang. Maka persalinan pun dapat berjalan lebih lancar dan singkat (Susanti et al., 2024).

## **H. Meditasi (*Meditation*)**

---

Meditasi merupakan pendekatan untuk mengatur emosi diri sendiri. Meditasi memiliki efek menguntungkan pada kesehatan fisik dan mental. Berbagai bentuk praktik meditasi berlaku dalam banyak agama dan budaya untuk kesejahteraan manusia. Meditasi menyebabkan perubahan neurokimia yang kompleks di otak. Perubahan neurokimia ini meliputi peningkatan dopamin, serotonin (5-hidroksitriptamin atau 5-HT), melatonin, asetilkolin, asam glutamat, asam amino N-asetil aspartat, glutamat, asam gamma-aminobutirat, dan dimetiltriptamin (DMT),

serta penurunan noradrenalin, kortisol, dan hormon pelepas kortikotropin di tingkat pusat. Ini juga meningkatkan aliran darah otak di area otak seperti lobus frontal, korteks prefrontal (PFC), talamus, hipokampus, hipotalamus, dan girus cingulate (Singh et al., 2024).

Menurut penelitian yang ada, meditasi telah terbukti memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan emosional selama kehamilan. Penelitian menyoroti bahwa wanita hamil yang melakukan praktik meditasi sering melaporkan penurunan tingkat stres, kecemasan, dan gejala depresi. Secara khusus, uji coba terkontrol acak yang melibatkan 46 wanita hamil, yang dilakukan oleh Matvienko-Sikar dan Dockray menemukan bahwa intervensi kesadaran dan rasa syukur daring, yang dipraktikkan empat kali seminggu selama tiga minggu, menghasilkan pengurangan stres prenatal yang signifikan. Pengurangan stres ibu ini sangat relevan, karena tingkat stres yang tinggi dikaitkan dengan hasil kehamilan yang merugikan (Liang, 2024).

Penelitian juga menemukan bahwa perawatan meditasi imajinasi terbimbing secara fisiologis meningkatkan respons kardiovaskular pada wanita hamil. Demikian pula, (Derakhshanpour et al., 2022) menunjukkan efek positif yang signifikan dari pelatihan kesadaran dalam meningkatkan kesejahteraan dan kontrol emosional pada 16 wanita hamil berdasarkan survei yang dilaporkan sendiri. Kemampuan meditasi untuk memelihara ketahanan emosional dan meningkatkan kejernihan mental membekali ibu hamil untuk mengatasi tantangan emosional yang melekat dalam kehamilan dengan lebih efektif. Selain itu, meditasi kesadaran menumbuhkan hubungan yang lebih dalam antara ibu dan bayinya yang sedang berkembang. Meskipun penelitian tambahan diperlukan untuk mengklarifikasi respons mekanis yang mendasarinya secara menyeluruh, literatur yang ada menekankan keefektifan meditasi dan melihatnya sebagai terapi yang berharga untuk meningkatkan kesejahteraan emosional selama kehamilan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesehatan mental ibu (Liang, 2024).

## **I. Teknik Pernapasan (*Breathing techniques*)**

---

Eksplorasi akademis teknik pernapasan untuk persiapan persalinan telah mengungkap potensi efek yang bermanfaat dari praktik ini bagi ibu hamil. Penelitian menunjukkan bahwa teknik ini, yang sering diintegrasikan ke dalam berbagai program pendidikan antenatal dan persalinan, memainkan peran penting dalam meningkatkan pengalaman persalinan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bastani, Hidarnia (2005), yang melibatkan 110 wanita hamil, mengungkapkan bahwa pelatihan relaksasi terapan selama 7 minggu secara signifikan mengurangi kecemasan dan stres yang dirasakan, yang menunjukkan potensinya untuk

meningkatkan kesejahteraan psikologis ibu selama kehamilan. Demikian pula, (Kamalifard et al., 2012) juga menemukan teknik pernapasan efektif dalam mengurangi rasa sakit selama persalinan dan menurunkan tingkat kecemasan. Dengan demikian, pola pernapasan yang terkontrol dan penuh perhatian yang diajarkan selama program ini dapat memberdayakan wanita untuk mengelola rasa sakit dan stres secara lebih efektif selama persalinan. Pernapasan diafragma yang dalam tidak hanya memberikan relaksasi tetapi juga meningkatkan oksigenasi, yang berpotensi menyebabkan durasi persalinan yang lebih pendek dan lebih sedikit komplikasi (Liang, 2024).

Uji coba acak yang melibatkan 60 wanita hamil menunjukkan bahwa melakukan latihan pernapasan diafragma selama 5 menit setiap hari selama 30 hari secara signifikan meningkatkan tingkat keterikatan ibu-janin dan menurunkan skor depresi, kecemasan, dan stres, yang menunjukkan manfaat psikologis yang positif. Studi-studi ini menunjukkan pentingnya pengendalian napas yang tepat sebagai alat yang berguna dalam mempersiapkan ibu hamil untuk tuntutan fisik dan emosional persalinan. Oleh karena itu, teknik pernapasan telah banyak digunakan pada wanita hamil untuk ketenangan meditatif dan persiapan persalinan (Liang, 2024).

Kesadaran napas memberikan kontrol fisik, mental, dan emosional. Bernapas dalam meningkatkan sirkulasi darah, aliran oksigen, dan mengurangi stres, yang bermanfaat bagi ibu dan bayi. Melalui pembelajaran teknik pernapasan dan relaksasi yang sadar, wanita dapat mengendalikan rasa sakit mereka secara lebih efektif dan rileks saat kontraksi rahim dimulai, sehingga meningkatkan kepercayaan diri (Leutenegger et al., 2024).

Ibu hamil perlu mempelajari cara menyesuaikan pola pernapasan mereka dengan kebutuhan masing-masing. Teknik pernapasan dan relaksasi hanya berguna dan praktis jika wanita dapat mencobanya dan menerapkannya dalam berbagai situasi sehari-hari. Teknik pernapasan dan relaksasi dapat digunakan pada hari apa pun dan dalam situasi yang membuat stres atau tidak nyaman. Oleh karena itu, penting bagi wanita untuk terus berlatih di rumah. Dalam kasus terbaik, teknik pernapasan dan relaksasi menjadi rutinitas atau menjadi sangat otomatis sehingga teknik tersebut secara otomatis diingat selama persalinan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Agar kebiasaan terbentuk, wanita perlu berlatih selama jangka waktu tertentu. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa rata-rata 66 hari diperlukan untuk mengingat latihan otomatis serupa. Periode waktu ini secara optimal bertepatan dengan dimulainya kelas pendidikan antenatal yang direkomendasikan pada trimester kedua (Leutenegger et al., 2024).

## **J. Akupresur dan refleksiologi (*Acupressure and reflexology*)**

---

Akupresur dan refleksiologi selama kehamilan telah mengungkapkan potensi keduanya sebagai pelengkap yang bermanfaat untuk perawatan prenatal konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa teknik non-invasif ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi ibu hamil. Akupresur dan refleksiologi, dengan fokus pada titik dan zona tekanan tertentu, telah terbukti efektif meredakan ketidaknyamanan umum selama kehamilan, termasuk mual, sakit kepala, dan nyeri punggung bawah. Akupresur dan refleksiologi telah terbukti sebagai metode alami untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan selama kehamilan, menghadirkan cara alternatif dan pelengkap untuk mengelola nyeri dan ketidaknyamanan pada fase kehamilan (Liang, 2024).

Pijat refleksi (*reflexology*) adalah metode manual untuk menerapkan terapi komplementer. Praktik ini melibatkan pemberian tekanan dengan gerakan jari tertentu pada titik refleksi di tangan, kaki, dan telinga yang berhubungan dengan kelenjar, organ, dan bagian tubuh. Tekanan yang diberikan merangsang ujung-ujung saraf untuk menghasilkan pesan elektrokimia. Kristal kalsium, asam laktat, dan asam urat yang terkumpul di ujung-ujung saraf dipecah. Tekanan juga meningkatkan aliran darah dan mempercepat ekskresi metabolit dari tubuh. Meskipun durasi sesi refleksi bervariasi menurut penyakit dan gejala, setiap sesi harus berdurasi 10 hingga 60 menit, dan enam hingga delapan sesi direkomendasikan sekali atau dua kali seminggu untuk mendapatkan hasil terapeutik (Kilicli, Aysegul and Zeyneloglu, 2024).

Akupresur adalah pengobatan non-obat yang merangsang tubuh untuk melepaskan zat kimia, seperti  $\beta$ -endorfin, dopamin, dan adrenalin, secara memadai dengan memberikan tekanan yang tepat pada titik akupunktur di meridian untuk mempertahankan fungsi normal tubuh untuk memperkuat ketenangan, meningkatkan kesehatan, dan mengobati penyakit. Akupresur merupakan pengobatan tradisional Tiongkok (TCM). TCM percaya bahwa energi penting dalam tubuh manusia, Qi, mengalir dalam saluran subkutan yang tak terlihat dan tak tersentuh, yang disebut meridian, untuk memberikan kekuatan bagi tubuh (Gong, Jie; Gu, Dandan; Wang, Hui; Zhang et al., 2024).

Rekomendasi untuk akupresur mencakup ketiga trimester kehamilan, yang menawarkan ibu hamil pilihan terapi yang potensial untuk berbagai ketidaknyamanan. Di sisi lain, rekomendasi untuk fokus pada refleksi selama trimester kedua dan ketiga bagi ibu hamil, didasarkan pada pertimbangan keamanan dan potensi manfaat. Pada trimester pertama, mungkin ada kekhawatiran tentang pemicu mual atau memengaruhi area sensitif melalui refleksi, yang

berpotensi memperburuk gejala-gejala ini. Saat kehamilan berlanjut ke trimester kedua dan ketiga, refleksi dapat memberikan manfaat dalam hal relaksasi, pengurangan stres, dan mengatasi ketidaknyamanan tertentu yang terkait dengan tahap selanjutnya. Pilihan untuk menekankan refleksi selama periode ini sejalan dengan pemberian terapi yang lebih mungkin ditoleransi dengan baik dan bermanfaat dalam mengatasi kebutuhan ibu hamil yang terus berkembang selama tahap akhir kehamilan (Liang, 2024).

### ***K. Tai Chi for physical and Mental Health***

---

Eksplorasi *Tai Chi* sebagai praktik untuk kesehatan fisik dan mental selama kehamilan telah mendapatkan perhatian akademis yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. *Tai Chi* terdiri dari gerakan-gerakan rumit, termasuk elemen-elemen seperti jongkok, yang dipadukan dengan pernapasan dalam untuk mencapai keadaan rileks dan mengurangi rasa sakit. Ini adalah latihan dan pelatihan meditasi yang berfokus pada imajinasi aliran Qi (para praktisi menganggap diri mereka sebagai balon yang mengembang dan menyusut) melalui pernapasan perut yang dapat mengurangi kecemasan prenatal, stres, dan risiko kelahiran prematur (Liang, 2024).

Berdasarkan penerapan dan aksesibilitasnya yang mudah, *Tai Chi* dapat menjadi praktik yang tepat dan dapat diterima untuk wanita hamil. Latihan pikiran-tubuh ini, yang ditandai dengan gerakan yang lambat dan mengalir serta napas dalam, dapat meningkatkan kebugaran fisik, meningkatkan fleksibilitas, dan mengurangi stres dan kecemasan selama kehamilan. Fokus *Tai Chi* pada keseimbangan dan relaksasi sejalan dengan perubahan fisiologis dan emosional yang terkait dengan kehamilan, menjadikannya sebagai latihan terapi yang berharga untuk mengelola ketidaknyamanan umum. Selain itu, *Tai Chi* dapat memberikan kontribusi pada rasa ketenangan dan kesadaran, yang sangat bermanfaat bagi kesehatan mental ibu (Liang, 2024).

Field, Diego (2013) menemukan bahwa intervensi gabungan *Tai Chi* dan yoga selama 12 minggu mengurangi depresi, kecemasan, dan meningkatkan kualitas tidur pada wanita hamil. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa intervensi *Tai Chi* selama 20 minggu selama kehamilan menstabilkan tekanan darah, menurunkan akumulasi lemak, dan meningkatkan kekebalan tubuh, sekaligus mengurangi nyeri punggung bawah dan meningkatkan kecemasan, depresi, dan stabilitas emosional untuk menguji kemanjurannya untuk lebih mengembangkan program berbasis bukti (Liang, 2024).

Rekomendasi untuk *Tai Chi* mencakup ketiga trimester kehamilan, yang memberikan ibu hamil praktik pikiran-tubuh yang holistik dan lembut yang meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Meskipun *Tai Chi* dapat bermanfaat sepanjang perjalanan kehamilan, menekankan praktiknya pada trimester pertama dan ketiga sejalan dengan keuntungan tertentu (yaitu, peningkatan kebugaran fisik, peningkatan fleksibilitas, dan pengurangan stres dan kecemasan) yang mungkin sangat berharga selama tahap-tahap ini (Esteban A., Oyarzabal; Barbara, Seufferling; Shaweta, Barbar; Shannon, Lawton-O'Boyle; Shilpa, 2021).

## **L. Penutup**

---

Kesehatan mental prenatal menjadi perhatian publik yang semakin meningkat. Saat ini, telah terbukti bahwa peningkatan aktivitas fisik efektif dalam meningkatkan kesehatan mental ibu hamil. Namun, kesehatan mental mungkin bergantung tidak hanya pada jumlah waktu yang dihabiskan untuk aktivitas tertentu, tetapi juga pada intensitas dan jenis aktivitas yang digantikannya.

Aktivitas fisik mengacu pada aktivitas tubuh apa pun dimana gerakan otot rangka menghasilkan pengeluaran energi, dan mewujudkan serangkaian jenis aktivitas termasuk olahraga, rekreasi, dan aktivitas keluarga dan profesional. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia memperbarui pedoman untuk perilaku menetap dan aktivitas fisik pada tahun 2020, mendorong wanita hamil untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik intensitas sedang (150 menit/minggu) dalam pekerjaan rumah tangga dan kehidupan sehari-hari.

## Referensi

- Alpert, P. T. (2011). The health benefits of dance. *Home Health Care Management and Practice*, 23(2), 155–157. <https://doi.org/10.1177/1084822310384689>
- Connolly, C. P., Conger, S. A., Montoye, A. H. K., Marshall, M. R., Schlaff, R. A., Badon, S. E., & Pivarnik, J. M. (2019). Walking for health during pregnancy: A literature review and considerations for future research. *Journal of Sport and Health Science*, 8(5), 401–411. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2018.11.004>
- Derakhshanpour, V., Pashasharifi, H., & Kadivar, P. (2022). *Effect of Mindfulness Training on well-being and Emotional Control of Nulliparous Pregnant Women*. 29(4).
- Duchette, C., Perera, M., Arnett, S., White, E., Belcher, E., & Tinius, R. (2024). Benefits of Resistance Training During Pregnancy for Maternal and Fetal Health: A Brief Overview. *International Journal of Women's Health*, 16(June), 1137–1147. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S462591>
- Esteban A., Oyarzabal; Barbara, Seufferling; Shaweta, Barbar; Shannon, Lawton-O'Boyle; Shilpa, B. (2021). Mind-Body Techniques in Pregnancy and Postpartum. *Clinical Obstetrics and Gynecology*, 64(3), 683–703. <https://doi.org/DOI:10.1097/GRF.0000000000000641>
- Gönenç, İ. M., & Dikmen, H. A. (2020). Effects of Dance and Music on Pain and Fear During Childbirth. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, Volume 49*(2), 144–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jogn.2019.12.005>
- Gong, Jie; Gu, Dandan; Wang, Hui; Zhang, F., Shen, Wangqin; Yan, H., & Juan, X. (2024). Effect of acupuncture in nausea and vomiting treatment during pregnancy: A meta-analysis. *Explore*, 20(1), 17–26. <https://doi.org/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550830723001684?via%3Dihub>
- Gordon, C. (2019). Physical activity in pregnancy: practical advice for women who run. *British Journal of Midwifery*, 7(24). <https://doi.org/https://doi.org/10.12968/bjom.2019.27.4.214> View article
- Kamalifard, M., Shahnazi, M., Sayyah Melli, M., Allahverdizadeh, S., Toraby, S., & Ghahvechi, A. (2012). The efficacy of massage therapy and breathing techniques on pain intensity and physiological responses to labor pain. *Journal of Caring Sciences*, 1(2), 73–78. <https://doi.org/10.5681/jcs.2012.011>
- Kilicli, Aysegul and Zeyneloglu, S. (2024). Effect of Reflexology on Pain, Fatigue, Sleep Quality, and Lactation in Postpartum Primiparous Women After Cesarean Delivery: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Human Lactation*, 40(2), 221–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/08903344241232982>

- Kuder, L., Dinevski, D., Dinevski, I. V., Takač, I., Mujezinović, F., & Gašparović, V. E. (2024). Benefits of yoga in pregnancy: a randomised controlled clinical trial. *Journal of Perinatal Medicine*, 1–8. <https://doi.org/10.1515/jpm-2024-0422>
- Leutenegger, V., Wieber, F., Daly, D., Sultan-Beyer, L., Bagehorn, J., & Pehlke-Milde, J. (2024). Study protocol of a breathing and relaxation intervention included in antenatal education: A randomised controlled trial (BreLax study). *PloS One*, 19(10), e0308480. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308480>
- Liang, I. J. (2024). The wonders of mind-body practices during pregnancy: A topical review. *Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology*, 63(4), 486–491. <https://doi.org/10.1016/j.tjog.2024.04.007>
- Petrovic, Danica, Milan Perovic, B. L., & Pantic, I. (2016). Association between walking, dysphoric mood and anxiety in late pregnancy: A cross-sectional study. *Psychiatry Research*, Volume 246, 360–363. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.10.009>
- Rodrigues-Denize, N., Zolnikov, B. T. R., & Furio, F. (2024). A systematic review on the physical, mental, and occupational effects of exercise on pregnant women. *Dialogues in Health*, 4(April). <https://doi.org/10.1016/j.dialog.2024.100181>
- Sah, L. K., Hatzidimitriadou, E., Wier, J., & Sah, R. K. (2024). Social determinants of the mental health of pregnant women in Nepal: Stakeholder perspectives. *PLoS ONE*, 19(12), 1–13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0314736>
- Simsek Sahin, E., & Can Gürkan, Ö. (2023). The Effect of Prenatal Yoga on Pregnancy-Related Symptoms: A Pilot Quasi-Experimental Study. *Complementary Medicine Research*, 30(3), 195–203. <https://doi.org/10.1159/000528801>
- Singh, A. K., Pathak, U., Kaur, P., & Dhakad, R. (2024). *Meditation as a Therapy or a Threat: A Case Series*. 16(12). <https://doi.org/10.7759/cureus.75201>
- Song, B., Wang, D., Yan, X., Yan, P., Liu, H., Li, H., & Yi, S. (2024). Physical activity and sleep quality among pregnant women during the first and second trimesters are associated with mental health and adverse pregnancy outcomes. *BMC Women's Health*, 24(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12905-024-03126-8>
- Susanti, Hassan, H. C., & Aljaberi, M. A. (2024). Pregnancy exercise effectiveness on anxiety level among pregnant women. *Journal of Public Health Research*, 13(2). <https://doi.org/10.1177/22799036241246701>



## Glosarium

***Prenatal Yoga*** adalah latihan tubuh dan pikiran. Yoga adalah sistem berbagai pose (asana) dan latihan peregangan yang dikombinasikan dengan pernapasan (pranayama) dan meditasi (dharana).

***Meditation*** adalah intervensi pengobatan integratif yang membantu memfokuskan perhatian untuk mencapai kondisi mental yang tenang, konsentrasi, dan emosi positif. Intervensi meditasi telah terbukti efektif dalam mengurangi keparahan nyeri, kecemasan, stres, dan depresi.

***Resistance Training*** adalah jenis latihan ketiga yang paling umum dilakukan oleh wanita saat hamil dan merupakan bentuk latihan yang meningkatkan kekuatan otot dengan menggunakan beban atau pita resistensi.

***Tai Chi*** adalah latihan pikiran-tubuh, yang ditandai dengan gerakan yang lambat dan mengalir serta napas dalam, yang terdiri dari gerakan-gerakan rumit, termasuk elemen-elemen seperti jongkok, yang dipadukan dengan napas dalam untuk mencapai keadaan rileks dan mengurangi rasa sakit

***Acupressure*** adalah pengobatan non-farmakologi yang merangsang tubuh untuk melepaskan zat kimia, seperti  $\beta$ -endorfin, dopamin, dan adrenalin, secara memadai dengan memberikan tekanan yang tepat pada titik akupunktur di meridian untuk mempertahankan fungsi normal tubuh untuk memperkuat ketenangan, meningkatkan kesehatan, dan mengobati penyakit.

***Reflexology*** adalah pijat refleksi dengan metode manual untuk menerapkan terapi komplementer. Praktik ini melibatkan pemberian tekanan dengan gerakan jari tertentu pada titik refleksi di tangan, kaki, dan telinga yang berhubungan dengan kelenjar, organ, dan bagian tubuh.

# BAB IV

## PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK LAYANAN KONSELING JARAK JAUH

---

### A. Pendahuluan

---

Dalam era digital yang berkembang pesat, teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan mental. Salah satu inovasi yang semakin mendapat perhatian adalah layanan konseling jarak jauh, yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan dukungan psikologis kepada individu tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Dengan adanya kemajuan dalam komunikasi digital, layanan ini mampu menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan bantuan psikologis, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan konseling konvensional.

Teknologi telah membuka peluang bagi profesional di bidang konseling untuk memberikan layanan dengan cara yang lebih fleksibel dan efisien. Platform digital seperti aplikasi mobile, panggilan video, chat berbasis teks, serta kecerdasan buatan memungkinkan individu untuk mendapatkan layanan konseling kapan saja dan di mana saja. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, memiliki mobilitas terbatas, atau merasa lebih nyaman mendapatkan bantuan tanpa harus datang langsung ke pusat layanan kesehatan mental.

Pemanfaatan teknologi dalam konseling jarak jauh tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pasien, tetapi juga membantu para konselor dalam mengelola jadwal dan menangani lebih banyak klien tanpa harus terbatas oleh lokasi geografis. Dengan sistem yang terintegrasi secara digital, para profesional dapat mendokumentasikan perkembangan klien, menyusun rencana terapi, serta memberikan materi pendukung yang dapat diakses kapan saja oleh pasien. Ini meningkatkan efektivitas layanan sekaligus memastikan adanya keberlanjutan dalam proses terapi.

Namun, meskipun memiliki banyak keuntungan, layanan konseling berbasis teknologi juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah masalah privasi dan keamanan data, keterbatasan dalam membangun hubungan emosional yang kuat antara konselor dan pasien, serta kemungkinan adanya hambatan teknis yang dapat mengganggu kelancaran sesi konseling. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan standar yang jelas untuk memastikan bahwa layanan ini dapat berjalan dengan optimal tanpa mengorbankan aspek etika dan profesionalisme.

Pemerintah dan berbagai institusi terkait juga perlu berperan aktif dalam mendorong pengembangan layanan konseling jarak jauh yang aman dan berkualitas. Dukungan kebijakan yang jelas, pelatihan bagi para konselor dalam penggunaan teknologi, serta edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara mengakses layanan ini menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini. Kolaborasi antara sektor kesehatan, teknologi, dan pendidikan dapat menciptakan ekosistem layanan konseling yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, masa depan layanan konseling jarak jauh memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas. Inovasi dalam komunikasi digital, peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, serta dukungan dari berbagai pihak akan menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa layanan ini dapat berfungsi secara optimal. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dalam layanan konseling tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga membantu membangun masyarakat yang lebih sehat secara mental dan emosional.

## **B. Konsep Dasar Konseling Jarak Jauh**

---

### **1. Pengertian Konseling**

Konseling jarak jauh merupakan bentuk layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan tanpa pertemuan tatap muka secara langsung antara konselor dan klien. Layanan ini memanfaatkan berbagai teknologi komunikasi seperti telepon, email, aplikasi pesan instan, dan video konferensi untuk memberikan dukungan psikologis kepada individu yang membutuhkan. (Haryati, 2020) Perkembangan teknologi menjadikan konseling jarak jauh semakin populer dan menjadi solusi bagi mereka yang mengalami kendala geografis atau keterbatasan mobilitas.

Konseling jarak jauh merupakan inovasi dalam layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan individu mendapatkan bantuan psikologis tanpa harus bertemu langsung dengan konselor. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, konseling jarak jauh semakin mendapat perhatian di dunia profesional. Awalnya, layanan ini terbatas pada konseling melalui telepon, tetapi kini telah berkembang mencakup video konsultasi, aplikasi berbasis chat, hingga platform berbasis kecerdasan buatan. Perkembangan ini membuka peluang bagi lebih banyak individu untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan mental secara lebih luas dan efisien.

### **2. Manfaat Konseling Jarak Jauh :**

Konseling jarak jauh merupakan salah satu inovasi dalam dunia kesehatan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan bimbingan dan konsultasi tanpa harus bertemu langsung. Dengan adanya kemajuan digital,

individu kini dapat mengakses layanan konseling melalui berbagai platform, seperti telepon, video call, atau aplikasi pesan instan. Berikut ini beberapa manfaat konseling jarak jauh :

**a. Aksesibilitas**

Konseling jarak jauh memungkinkan pasien yang berada di daerah terpencil atau mempunyai keterbatasan mobilitas untuk mendapatkan layanan konseling tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan.

**b. Fleksibilitas waktu dan tempat**

Pasien dapat memilih waktu dan tempat yang nyaman untuk melakukan sesi konseling. Konseling dapat dilakukan di waktu yang lebih fleksibel dibandingkan pertemuan tatap muka.

**c. Efisiensi biaya dan waktu**

Konseling jarak jauh dapat mengurangi biaya perjalanan serta operasional bagi pasien maupun konselor. Selain itu, waktu yang biasanya digunakan untuk pergi ke tempat konseling dapat digunakan secara lebih produktif.

**d. Privasi dan kenyamanan**

Memberikan kenyamanan bagi pasien yang merasa enggan untuk mengakses layanan tatap muka.

**e. Dukungan Kontinu**

Memungkinkan konselor untuk tetap terhubung dengan pasien dalam jangka panjang. (Richards & Richardson, 2012)

**3. Etika dan Privasi dalam Konseling Daring**

Dalam melakukan konseling jarak jauh juga dibutuhkan etika dalam melakukan konseling. Berikut ini etika yang harus diperhatikan konselor dalam melakukan konseling:

**a. Kerahasiaan dan privasi**

Konselor bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi pasien. Data yang dikumpulkan selama sesi daring harus dienkripsi dan disimpan dengan aman agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang.

**b. Keamanan data dan teknologi**

Penggunaan platform komunikasi yang terenkripsi (misalnya, Zoom dengan enkripsi end-to-end atau aplikasi khusus terapi seperti BetterHelp) harus menjadi prioritas. Konselor juga harus menghindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik yang rentan terhadap peretasan.

**c. Persetujuan *informed consent***

Sebelum memulai sesi konseling daring, konselor wajib memberikan informasi lengkap kepada klien mengenai metode komunikasi, risiko

keamanan, serta keterbatasan layanan. Pasien harus menandatangani persetujuan (*informed consent*) sebelum sesi dimulai.

**d. Batasan profesionalisme dan hubungan konselor-pasien**

Konselor harus menjaga batas profesional dengan tidak terlibat dalam hubungan non-profesional dengan klien, termasuk melalui media sosial. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa komunikasi tetap berada dalam batas-batas etika profesional.

**e. Kredibilitas dan kompetensi konselor**

Konselor harus memiliki pelatihan yang memadai dalam memberikan layanan daring. Selain itu, mereka harus memahami bagaimana teknologi dapat memengaruhi proses terapi dan bagaimana menangani kendala teknis yang mungkin muncul. (Bastomi, 2019)

Berbagai lembaga telah mengembangkan pedoman dan regulasi konseling jarak jauh untuk memastikan keamanan serta efektivitas layanan. Organisasi seperti American Psychological Association (APA) dan World Health Organization (WHO) memberikan panduan tentang standar praktik, persetujuan informasi, serta perlindungan data klien. Di beberapa negara, pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi untuk memastikan bahwa layanan ini memenuhi standar profesional yang diperlukan.

## **C. Metode dan Teknik Konseling Jarak Jauh**

---

Konseling jarak jauh telah menjadi solusi yang efektif dalam memberikan dukungan psikologis kepada ibu hamil, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental konvensional. Teknologi memungkinkan konselor untuk memberikan layanan yang lebih fleksibel, efisien, dan mudah diakses, tanpa mengurangi kualitas interaksi antara konselor dan pasien.

Kehamilan merupakan fase yang penuh dengan perubahan emosional dan fisik, yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis seorang ibu. Stres, kecemasan, dan depresi selama kehamilan dapat berdampak pada kesehatan ibu dan janin. Oleh karena itu, konseling berperan penting dalam membantu ibu hamil mengelola emosi, memberikan informasi yang relevan, serta membangun dukungan sosial yang kuat.

Metode konseling jarak jauh merupakan perkembangan teknologi untuk memudahkan akses terhadap layanan kesehatan mental. Berikut adalah beberapa macam konseling jarak jauh yang umum digunakan:

**1. Konseling melalui telepon (telekonseling)**

Konseling ini menggunakan telepon melalui percakapan suara, efektif untuk pasien yang tidak memiliki akses ke internet. Metode ini memberikan

kemudahan bagi individu yang merasa lebih nyaman berbicara tanpa tatap muka serta tetap menjaga anonimitas.

## **2. Konseling melalui video call**

Konseling ini dapat menggunakan platform seperti Zoom, Google Meet, atau Skype untuk berinteraksi secara tatap muka secara virtual. Dengan adanya komunikasi tatap muka secara virtual, konselor dapat membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh klien, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif.

## **3. Konseling melalui chat atau pesan teks**

Konseling berbasis pesan dapat dilakukan melalui email, SMS, atau aplikasi chat seperti WhatsApp dan telegram. Metode ini cocok bagi mereka yang lebih nyaman mengungkapkan perasaan melalui tulisan dan dapat memberikan kesempatan untuk merenungkan setiap tanggapan.

## **4. Konseling melalui e-mail**

Konseling dengan metode ini, pasien mengirimkan pertanyaan melalui email. Balasan dari konselor dilakukan secara tertulis melalui email. Konseling jenis ini memungkinkan refleksi lebih mendalam karena pasien dapat membaca kembali respon yang diberikan.

## **5. Konseling melalui aplikasi atau platform digital**

Banyak aplikasi dan situs web yang menyediakan layanan konseling daring, baik berbasis teks maupun video. Konseling berbasis platform digital memberikan kemudahan akses dan fleksibilitas dalam memilih konselor sesuai kebutuhan individu. (Kusnadi, 2021)

Teknik yang digunakan dalam konseling jarak jauh harus disesuaikan dengan media komunikasi yang digunakan. Beberapa teknik utama yang sering diterapkan meliputi:

### **1. Teknik refleksi dan validasi emosi**

Teknik ini digunakan untuk membantu klien merasa dipahami dan diterima, terutama dalam konseling berbasis teks dan telepon di mana komunikasi nonverbal terbatas.

### **2. Teknik Kognitif-Behavioral (CBT) berbasis digital**

Teknik CBT sering diterapkan dalam konseling online melalui modul interaktif yang membantu klien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif.

### **3. Teknik motivational interviewing (MI)**

Teknik ini digunakan untuk membantu klien menemukan motivasi intrinsik mereka untuk berubah. Teknik MI sangat efektif dalam konseling berbasis pesan teks dan email karena memberikan waktu bagi klien untuk merefleksikan jawaban mereka.

### **4. Teknik mindfulness dan relaksasi digital**

Beberapa layanan konseling jarak jauh menyediakan latihan mindfulness dan teknik relaksasi berbasis aplikasi untuk membantu klien mengelola stres dan kecemasan secara mandiri.

Beberapa pendekatan terapi yang digunakan dalam konseling jarak jauh untuk kesehatan mental ibu hamil meliputi:

**1. Terapi Kognitif-Behavioral (Cognitive-Behavioral Therapy/CBT) Online**

Pendekatan ini membantu ibu hamil mengenali dan mengubah pola pikir negatif yang berkontribusi terhadap kecemasan dan depresi prenatal. Program berbasis CBT online dapat diberikan melalui aplikasi, platform web, atau sesi telekonseling dengan psikolog.

**2. Terapi dukungan emosional (supportive therapy)**

Terapi ini bertujuan untuk memberikan validasi emosi dan dukungan psikologis bagi ibu hamil yang mengalami stres atau kecemasan. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui telepon atau chat untuk memberikan kenyamanan bagi klien dalam berbagi pengalaman mereka.

**3. Terapi mindfulness dan relaksasi berbasis digital**

Pendekatan ini berfokus pada teknik meditasi, pernapasan, dan kesadaran diri untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional ibu hamil. Aplikasi mindfulness dan program berbasis web telah terbukti efektif dalam menurunkan kecemasan prenatal.

**4. Terapi interpersonal (interpersonal therapy/IPT) berbasis virtual**

IPT digunakan untuk membantu ibu hamil yang mengalami depresi dengan meningkatkan keterampilan komunikasi dan hubungan interpersonal. Layanan ini dapat diberikan melalui video call atau platform berbasis teks yang memungkinkan klien untuk mengungkapkan perasaan mereka secara mendalam.

**5. Terapi berbasis chatbot dan aplikasi digital**

Chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk memberikan intervensi awal dan dukungan psikologis bagi ibu hamil yang mengalami kecemasan ringan hingga sedang. Aplikasi ini dapat memberikan edukasi serta latihan relaksasi untuk membantu mengelola stres.

## **D. Tantangan dan Solusi dalam Konseling Jarak Jauh**

---

Konseling jarak jauh merupakan pendekatan inovatif yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan kesehatan mental tanpa memerlukan pertemuan tatap muka. Namun, pelaksanaannya juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitasnya. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan solusi yang tepat agar layanan konseling jarak jauh dapat berjalan

dengan optimal. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam konseling jarak jauh:

**1. Keterbatasan dalam membaca ekspresi nonverbal**

Tidak semua bentuk komunikasi nonverbal dapat ditangkap secara akurat melalui media digital. Keterbatasan nonverbal ini dapat memberikan pasien kurang paham akan penjelasan dari konselor.

**2. Keamanan dan Privasi Data**

Data pasien merupakan data rahasia yang perlu dijaga. Perlindungan informasi pasien menjadi isu penting yang harus diperhatikan.

**3. Kesiapan Teknologi**

Keterbatasan akses ke perangkat dan jaringan internet dapat menjadi kendala. Tidak semua wilayah di Indonesia sudah memiliki jaringan internet.

**4. Kredibilitas dan Etika**

Konselor harus memastikan bahwa mereka memiliki kualifikasi yang sesuai serta mengikuti standar etika profesi.

**5. Koneksi dan Infrastruktur**

Konseling dengan menggunakan teknologi sering terjadi masalah teknis seperti gangguan jaringan dapat menghambat efektivitas sesi konseling.(Rimayati et al., 2023)

Terdapat beberapa solusi untuk mengatasi tantangan dalam konseling jarak jauh, yaitu :

**1. Menggunakan Teknologi Berbasis Video**

Konseling berbasis video dapat membantu mengurangi keterbatasan komunikasi nonverbal dengan memungkinkan konselor untuk melihat ekspresi wajah dan bahasa tubuh klien.

**2. Meningkatkan Keamanan dan Privasi Data**

Penyedia layanan harus memastikan bahwa mereka menggunakan platform yang terenkripsi dan mematuhi regulasi perlindungan data, seperti HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) di Amerika Serikat atau GDPR (General Data Protection Regulation) di Eropa.

**3. Menyediakan Alternatif bagi Klien dengan Akses Teknologi Terbatas**

Untuk mengatasi keterbatasan akses teknologi, layanan konseling dapat menggunakan pendekatan berbasis telepon sebagai alternatif bagi mereka yang tidak memiliki koneksi internet stabil.

**4. Membangun Aliansi Terapeutik Secara Virtual**

Konselor dapat menggunakan teknik komunikasi yang empatik, seperti validasi emosi dan refleksi perasaan, untuk membantu membangun hubungan yang lebih kuat dengan klien dalam sesi virtual.

**5. Pelatihan bagi Konselor dan Klien dalam Penggunaan Teknologi**



Mengadakan pelatihan bagi konselor dalam penggunaan teknologi dan strategi komunikasi virtual dapat meningkatkan efektivitas layanan. Selain itu, panduan penggunaan platform digital bagi klien juga dapat membantu mereka lebih nyaman dalam sesi konseling. (Berger, 2017)

## **E. Strategi Efektif dalam Konseling Jarak Jauh**

---

Konseling jarak jauh telah menjadi solusi yang semakin populer untuk memberikan layanan kesehatan mental yang lebih mudah diakses. Meskipun efektif, metode ini memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus agar konseling jarak jauh dapat berjalan secara optimal. Berikut adalah strategi-strategi efektif dalam konseling jarak jauh yang dapat diterapkan oleh konselor dan pasien.

### **1. Membangun hubungan terapeutik secara virtual**

Hubungan terapeutik merupakan elemen penting dalam proses konseling yang melibatkan rasa percaya, keterbukaan, dan kerja sama antara konselor dan pasien. Dalam konteks virtual, membangun hubungan terapeutik memiliki tantangan tersendiri karena keterbatasan komunikasi non-verbal dan kemungkinan hambatan teknologi. Namun, dengan strategi yang tepat, hubungan terapeutik yang kuat tetap dapat tercapai melalui konseling jarak jauh. Prinsip dasar dalam membangun hubungan terapeutik pada konseling virtual sebagai berikut:

#### **a. Empati dan kehadiran aktif**

- 1) Konselor harus menunjukkan empati secara verbal dan non-verbal meskipun berada di lingkungan virtual.
- 2) Memberikan umpan balik yang jelas, seperti mengulang atau merangkum pernyataan pasien, dapat membantu menunjukkan bahwa konselor benar-benar memahami perasaan dan pengalaman pasien.

#### **b. Membangun kepercayaan (*trust building*)**

- 1) Pasien harus merasa nyaman dan aman dalam berbagi informasi pribadi.
- 2) Konselor perlu menjelaskan kebijakan privasi, keamanan data, dan batasan komunikasi daring sejak awal sesi.

#### **c. Komunikasi yang efektif**

- 1) Menggunakan bahasa yang jelas dan ekspresi yang mendukung.
- 2) Menyesuaikan nada suara dan tempo berbicara untuk menciptakan suasana yang nyaman.

#### **d. Menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan pasien**

- 1) Setiap klien memiliki preferensi berbeda dalam komunikasi daring.

- 2) Konselor perlu menyesuaikan pendekatan, seperti menggunakan video call bagi klien yang lebih nyaman dengan interaksi visual atau chat bagi mereka yang merasa lebih nyaman menulis.

## **2. Teknik konseling yang cocok untuk media digital**

Konseling berbasis media digital memerlukan teknik khusus agar tetap efektif meskipun dilakukan tanpa interaksi fisik langsung. Perbedaan antara komunikasi tatap muka dan komunikasi daring, seperti keterbatasan komunikasi non-verbal dan potensi gangguan teknologi, membuat konselor perlu menyesuaikan metode yang digunakan. Berikut adalah beberapa teknik konseling yang terbukti cocok untuk media digital:

### **a. Teknik refleksi dan validasi emosi**

#### **1) Refleksi perasaan**

Teknik ini digunakan untuk membantu pasien merasa dipahami dengan mengulang atau merangkum perasaan yang telah mereka ungkapkan. Dalam konseling digital, refleksi ini bisa dilakukan dengan:

- a) Video call: Menggunakan ekspresi wajah dan nada suara yang mendukung.
- b) Chat/email: Menggunakan kalimat yang menunjukkan perasaan.

#### **2) Validasi emosi**

Teknik ini membantu klien merasa dihargai dan dimengerti. Dalam media digital, validasi dapat dilakukan dengan:

- a) Menyatakan bahwa emosi yang dirasakan pasien adalah benar.
- b) Menggunakan emoji atau tanda baca yang tepat dalam chat untuk mengekspresikan empati dengan tetap menjaga profesionalisme.

### **b. Teknik pertanyaan terbuka dan terfokus**

#### **1) Pertanyaan terbuka**

Teknik ini berguna untuk menggali lebih dalam pengalaman dan perasaan pasien.

#### **2) Pertanyaan terfokus**

Untuk pasien yang kesulitan mengekspresikan diri dalam media digital.

### **c. Teknik Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dalam konseling digital**

CBT adalah salah satu teknik yang paling sering digunakan dalam terapi digital karena berbasis struktur dan memiliki banyak alat bantu daring.

#### **1) Mengidentifikasi pikiran negatif**

#### **2) Restrukturisasi kognitif**

- a) Konselor membantu pasien mengganti pikiran negatif dengan yang lebih rasional.

- b) Dalam media digital, konselor bisa memberikan template untuk menuliskan keyakinan negatif dan alternatif pemikiran yang lebih sehat.

#### **d. Teknik psikoedukasi digital**

Psikoedukasi adalah teknik di mana konselor memberikan informasi kepada pasien untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kondisi psikologisnya. Dalam media digital, psikoedukasi dapat dilakukan dengan:

- 1) Mengirimkan artikel atau video edukasi yang relevan dengan masalah pasien.
- 2) Menggunakan infografis atau modul daring yang menjelaskan teknik manajemen stres, kecemasan, atau depresi.
- 3) Memanfaatkan aplikasi kesehatan mental yang memiliki fitur pelacakan suasana hati atau latihan mindfulness.

#### **e. Teknik penggunaan jurnal daring dan self-monitoring**

Teknik ini melibatkan pasien dalam mencatat perasaan, pikiran, dan perilaku mereka untuk mengevaluasi perkembangan terapi.

- 1) Menggunakan aplikasi jurnal digital untuk mencatat emosi harian.
- 2) Mengirimkan formulir refleksi sebelum sesi untuk membantu klien mengungkapkan perasaan mereka lebih jelas.

### **3. Evaluasi dan tindak lanjut dalam konseling jarak jauh**

Evaluasi dan tindak lanjut merupakan komponen penting dalam konseling online untuk memastikan efektivitas intervensi, memahami perkembangan klien, serta menyesuaikan strategi yang digunakan. Tanpa evaluasi yang baik, sulit bagi konselor dan pasien untuk mengukur kemajuan atau menyesuaikan pendekatan yang lebih sesuai.

Dalam konteks digital, evaluasi dan tindak lanjut dilakukan dengan cara yang berbeda dibandingkan konseling tatap muka. Peran teknologi menjadi krusial dalam mengumpulkan data, memberikan umpan balik, dan menjaga keterlibatan pasien secara berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai strategi dan metode yang digunakan dalam tahap evaluasi dan tindak lanjut dalam konseling online.

## **F. Implementasi Konseling Jarak Jauh**

---

Implementasi konseling jarak jauh membutuhkan kesiapan teknologi dan metode yang sesuai agar sesi konseling dapat berjalan efektif. Layanan ini dapat dilakukan secara sinkron, di mana konselor dan pasien berinteraksi secara langsung dalam waktu nyata melalui panggilan video atau telepon. Selain itu, metode

asinkron juga sering digunakan, seperti komunikasi melalui email atau pesan teks yang memungkinkan klien mengungkapkan perasaan mereka tanpa tekanan waktu. Pemilihan metode sangat bergantung pada preferensi klien dan jenis permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga fleksibilitas dalam pendekatan menjadi salah satu keunggulan utama konseling jarak jauh.(Mulawarman, 2024)

Tujuan implementasi konseling jarak jauh :

1. Mempermudah akses layanan konseling bagi individu yang memiliki keterbatasan mobilitas atau lokasi.
2. Menyediakan dukungan psikologis yang cepat dan efisien.
3. Mengurangi hambatan seperti waktu dan biaya perjalanan untuk mendapatkan layanan konseling.
4. Memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan konseling sesuai dengan kebutuhan klien.

Implementasi konseling jarak jauh dilakukan dengan beberapa langkah seperti:

1. Persiapan teknis
  - a. Memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi seperti perangkat dan jaringan internet yang stabil.
  - b. Memilih platform yang sesuai dengan kebutuhan konseling.
2. Persiapan etis dan profesional
  - a. Menjamin keamanan data dan privasi klien.
  - b. Mematuhi kode etik profesi terkait komunikasi jarak jauh.
3. Penyediaan layanan konseling
  - a. Menyediakan berbagai metode komunikasi sesuai preferensi klien.
  - b. Menerapkan teknik konseling yang efektif untuk format jarak jauh.
4. Evaluasi dan perbaikan layanan
  - a. Mengumpulkan feedback dari klien untuk meningkatkan kualitas layanan.
  - b. Melakukan pelatihan berkelanjutan bagi konselor untuk adaptasi dengan metode daring.

Keberhasilan implementasi konseling jarak jauh juga bergantung pada kesiapan profesionalisme konselor dalam menghadapi tantangan baru. Konselor harus terus mengembangkan keterampilan dalam memberikan bimbingan melalui media digital, termasuk memahami etika dalam komunikasi daring dan menjaga keterlibatan emosional klien meskipun dilakukan tanpa pertemuan langsung. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas layanan juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengalaman klien dan memastikan bahwa metode yang digunakan benar-benar membantu dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.(Siradjuddin, 2017)

## **G. Penutup**

---

Pemanfaatan teknologi dalam layanan konseling jarak jauh telah membawa perubahan signifikan dalam cara individu mengakses bantuan psikologis dan bimbingan. Dengan adanya berbagai platform digital, layanan konseling kini lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas, termasuk mereka yang sebelumnya menghadapi hambatan geografis, waktu, atau keterbatasan fisik.

Meskipun teknologi telah membuka banyak peluang, keberhasilannya tetap bergantung pada berbagai faktor, seperti kompetensi konselor dalam menggunakan media digital, keamanan data klien, serta efektivitas komunikasi dalam sesi daring. Oleh karena itu, pengembangan standar etika dan pedoman profesional dalam konseling jarak jauh menjadi sangat penting agar layanan ini tetap berkualitas dan dapat dipercaya.

Di masa depan, teknologi akan terus berkembang dan menghadirkan inovasi baru yang semakin meningkatkan efektivitas konseling jarak jauh. Integrasi kecerdasan buatan, realitas virtual, dan sistem berbasis data dapat menjadi langkah berikutnya dalam meningkatkan kualitas layanan psikologis secara lebih personal dan efisien.

## Referensi

- Bastomi, H. (2019). Konseling Cyber: Sebuah model konseling pada konteks masyarakat berbasis online. *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counselling*, 3(1), 19–36.
- Berger, T. (2017). The therapeutic alliance in internet interventions: A narrative review and suggestions for future research. *Psychotherapy Research*, 27(5), 511–524.
- Haryati, A. (2020). Online counseling sebagai alternatif strategi konselor dalam melaksanakan pelayanan e-counseling di era industri 4.0. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 2(2), 27–38.
- Kusnadi, F. N. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Anemia dengan Kejadian Anemia pada Remaja Putri. *Jurnal Medika Utama*, 3(01 Oktober), 1293–1298.
- Mulawarman, S. P. M. P. (2024). *Konseling Online: Konsep dan Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling di Era Digital*. Prenada Media. [https://books.google.co.id/books?id=t\\_oJEQAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=t_oJEQAAQBAJ)
- Richards, D., & Richardson, T. (2012). Computer-based psychological treatments for depression: a systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 32(4), 329–342.
- Rimayati, E., Pranadani, A., Ismail, A., & Teknologi, P. A. L. (2023). *Cyber Counseling: Inovasi Layanan Bimbingan dan Konseling Di Era Digital*. Asadel Liamsindo Teknologi. <https://books.google.co.id/books?id=oWvdEAAAQBAJ>
- Siradjuddin, H. K. (2017). Implementasi Prototype Aplikasi E-Konseling Untuk Menunjang Pelayanan Konseling Berbasis Jejaring Sosial. *IJIS-Indonesian Journal On Information System*, 2(2), 48–56.

# BAB V

## DUKUNGAN KELUARGA DALAM MENJAGA KESEHATAN MENTAL IBU HAMIL

---

### A. Pendahuluan

---

Kehamilan merupakan peristiwa yang beresiko terjadinya masalah kesehatan mental karena perubahan hormon reproduksi, perubahan peran, identitas diri dan sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi dan dukungan keluarga. Masalah mental masa kehamilan dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu hamil, kesejahteraan janin dan kematian bayi. Ibu hamil yang mengalami stress, cemas menunjukkan perilaku kurang peduli pada janin dan praktek perawatan kehamilan yang buruk berdampak pada masalah tumbuh kembang janin dan beresiko kelahiran BBLR dan SGA. Bayi berat lahir rendah, sistem termoregulasi belum berkembang baik, produksi surfaktan rendah, otot pernafasan masih lemah dan imunitas tubuh rendah sehingga mudah terjadi hipotermi, asfiksia dan infeksi yang memperberat kondisi bayi dan meningkatkan resiko kematian bayi (K. Wallace & Araj, 2020).

Ibu hamil sering kali mengalami berbagai masalah mental, termasuk kecemasan, yang dapat berlangsung sepanjang masa kehamilan. Salah satu penyebab kecemasan yang dialami oleh ibu hamil adalah penurunan kadar serotonin. Serotonin, atau 5-hydroxytryptamine (5HT), adalah neurotransmitter dalam sistem saraf pusat yang berfungsi mengirimkan sinyal antara otak dan sistem saraf pusat. Secara fisiologis, serotonin memiliki peran penting dalam mengatur perilaku, suasana hati, memori, nafsu makan, serta kualitas tidur (Bamalan *et al.*, 2022; Borroto-Escuela *et al.*, 2021). Penurunan kadar serotonin dapat meningkatkan kecemasan pada ibu hamil, yang pada gilirannya mengganggu aliran darah ke janin dan meningkatkan risiko lahirnya bayi dengan kondisi kesehatan yang buruk. Bagi ibu, hal ini dapat menyebabkan hipertensi, yang dapat berlanjut menjadi pre-eklampsia, serta memicu perdarahan postpartum dan depresi pasca persalinan, bahkan berpotensi menyebabkan kematian ibu.

Angka kematian ibu dan bayi (AKI dan AKB) menjadi perhatian utama dalam kebijakan global untuk mengatasi masalah kesehatan maternal dan bayi, sebagaimana tercantum dalam sasaran ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Salah satu targetnya adalah menurunkan AKI menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB menjadi 12 per 1.000 kelahiran hidup. Di Indonesia, target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 adalah AKI sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 16 per 1.000 kelahiran hidup.

Pelayanan kesehatan prenatal menjadi salah satu faktor kunci dalam mencapai penurunan AKI dan AKB yang berhasil (Bappeda DIY, 2021; United Nations Development Programme, 2020).

Dukungan keluarga berperan penting sebagai bentuk dukungan yang diterima oleh ibu hamil. Dukungan ini tidak hanya dirasakan oleh ibu hamil, tetapi juga menjadi harapan bagi mereka, mencerminkan ekspektasi serta pengakuan terhadap kebutuhan yang dimiliki selama masa kehamilan (Pasricha et al., 2021). Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara masalah psikologis yang dialami oleh ibu hamil, riwayat aborsi, dan kurangnya dukungan dari keluarga. Kehadiran keluarga dalam proses perawatan kehamilan berkontribusi pada penurunan tingkat kecemasan. Hal ini terlihat dari hasil pretest yang menunjukkan nilai rata-rata 2,10 (2,03) dan posttest dengan nilai 4,51 (2,92) pada kelompok intervensi. Sementara itu, pada kelompok kontrol, nilai pretest tercatat 2,12 (2,33) dan posttest 2,18 (2,62) (Yuan et al., 2020). Perhatian dan kasih sayang dari keluarga sangat berperan dalam membuat emosi ibu lebih stabil, tenang, dan bahagia. Selain itu, stimulasi dari ayah kepada janin, seperti sering mengajak bicara dan memberikan sentuhan, dapat menenangkan janin serta membangun ikatan emosional antara ayah dan janin. Suara dan sentuhan ini memiliki dampak positif pada perkembangan kognitif, emosi, dan sosial janin (Maziyatul et al., 2020).

Perhatian serta kasih sayang dari keluarga terbukti dapat membuat emosi ibu lebih stabil, tenang, dan bahagia. Stimulasi yang diberikan oleh ayah kepada janin melalui percakapan dan sentuhan tidak hanya menenangkan, tetapi juga membangun ikatan emosional antara janin dan ayah. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial janin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dukungan suami sangat berpengaruh terhadap rasa aman dan nyaman ibu hamil, yang pada gilirannya berpengaruh pada kesehatan ibu dan janin hingga proses persalinan. Keterlibatan keluarga pada kehamilan merupakan sumbu yang menghubungkan kecemasan, MFA dan hasil kelahiran. Hasil penelitian bahwa keluarga yang mendukung kehamilan cenderung berkontribusi menurunkan resiko kelahiran BBLR (OR:0,31; CI:0,47-0,85) dan abortus (OR:0,31; CI:0,28-0,34) (Shah et al., 2014).

## **B. Konsep Dukungan Keluarga Pada Ibu Hamil**

---

Dukungan keluarga mencerminkan sikap, tindakan, serta penerimaan yang diberikan anggota keluarga terhadap satu sama lain. Anggota keluarga merasa bahwa sosok yang bersikap mendukung selalu siap sedia untuk memberikan pertolongan dan bantuan ketika diperlukan (Goldstein et al., 2018). Pada dasarnya, keluarga diharapkan dapat mengenali proses membuka mutualitas kasih sayang dan



kasih sayang antara keluarga, antara kerabat, dan antargenerasi yang membentuk dasar keluarga yang lebih harmonis. Hubungan cinta keluarga adalah keluarga yang bahagia. Dalam kehidupan yang diwarnai oleh cinta, semua pihak harus memiliki tanggung jawab, korban, saling mendukung, kejujuran, rasa saling percaya, saling pengertian (Yoon & Sung, 2021).

Dukungan sosial yang diberikan atau diakses untuk keluarga disebut dukungan keluarga. Anggota keluarga percaya bahwa mendukung berarti selalu siap membantu jika diperlukan. Untuk ibu hamil, dukungan sosial keluarga dapat mencakup dukungan dari keluarga dalam, seperti suami, anak, orangtua, dan saudara kandung (Maharlouei, 2020).

Ibu hamil membutuhkan orang lain untuk berbicara dengan mereka dan membantu mereka dengan keadaan mereka. Keluarga, teman, tetangga, dan profesional kesehatan memberikan dukungan sosial kepada ibu hamil untuk memberikan kenyamanan fisik dan psikologis. Menyesuaikan diri dengan situasi kehamilan dan mengalami berbagai perubahan fisik dan psikologis adalah manfaat dari dukungan sosial yang diberikan kepada ibu hamil (Zefanya & Suryadi, 2021). Walaupun teman, keluarga, tenaga kesehatan, dan keluarga dapat memberikan dukungan sosial, yang paling penting bagi ibu hamil adalah keluarga, terutama pasangan (Al Owaifeer et al., 2018).

Dukungan dari pasangan adalah bentuk bantuan dan perlindungan emosional, serta informasi konkret yang disediakan oleh pasangan untuk ibu hamil. Pasangan merupakan anggota keluarga terdekat, sebagai sumber dukungan utama yang didasari oleh rasa saling percaya. Mereka adalah tempat berbagi cerita saat ibu ingin mengungkapkan masalahnya. Atensi dari pasangan terwujud melalui dukungan, perawatan, serta pemberian informasi, kasih sayang, sumber daya, dan pengakuan. Dukungan pasangan memainkan peran krusial dalam membentuk kesehatan ibu hamil dan janinnya. Dalam konteks ini, keterlibatan pasangan dalam kesehatan ibu menjelang kelahiran merupakan strategi yang perlu diperkuat, karena mereka berfungsi sebagai penjaga utama bagi kesehatan ibu dan bayi. Kualitas serta kuantitas dukungan yang diberikan oleh pasangan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, pengalaman dari berbagai sumber pembelajaran dari lingkungannya (teman, keluarga, orangtua), kesibukan, dan kondisi emosional pasangan (Zefanya & Suryadi, 2021).

Dukungan yang diberikan oleh pasangan mampu memperkuat rasa percaya diri dan kesadaran ibu hamil bahwa kehadiran serta kondisi kehamilannya diperhatikan, disayangi, dan dihargai sebagai anggota keluarga yang saling mendukung dan memerlukan, sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman. Bantuan dari pasangan memberi semangat yang besar kepada ibu hamil untuk menerima serta merawat kehamilannya. Ibu akan lebih relaks dan bahagia yang berkontribusi positif dalam mengurangi kecemasan serta meningkatkan ikatan emosional antara ibu, ayah, da

n janin. Dukungan pasangan dapat meningkatkan kesehatan fisik, respons terhadap kecemasan, produktivitas, kesejahteraan mental, dan kemampuan beradaptasi (Friedman, 2013). Individu yang menerima dukungan pasangan akan merasa dicintai, diperhatikan, dihargai, serta merasa dirinya bagian dari suatu sistem sosial yang dibutuhkan. Rasa aman karena dicintai, mempunyai pengaruh positif terhadap kesehatan fisik dan psikologis ibu dan janin.

Dukungan yang diberikan oleh suami dipengaruhi oleh sejumlah faktor: pendidikan, budaya, serta kondisi sosial ekonomi. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk perspektif dan akses terhadap informasi yang esensial untuk pengambilan keputusan. Budaya mencerminkan nilai dan kebiasaan yang dihayati dalam komunitas tempat tinggal, yang berpengaruh pada seberapa tepat suami memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan selama masa kehamilan. Sementara, kondisi sosial ekonomi berdampak pada berbagai bentuk dukungan suami, dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik memudahkan akses informasi, meningkatkan kemampuan emosional, pemenuhan kebutuhan material, serta pengakuan terhadap ibu hamil (Zefanya & Suryadi, 2021).

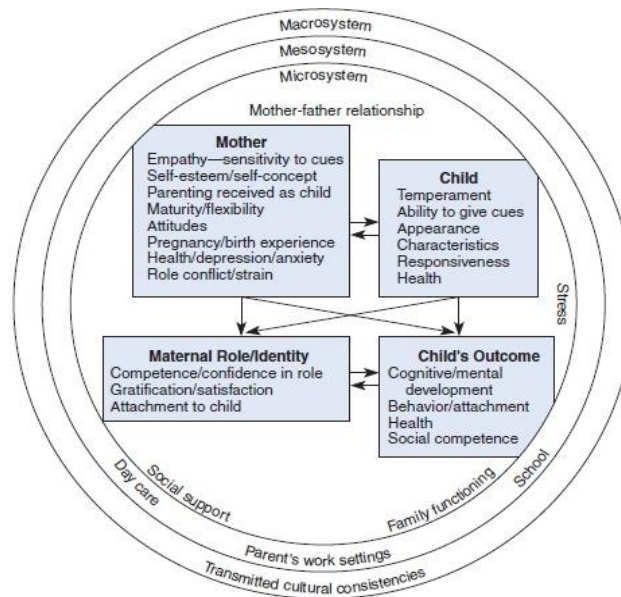
### **C. Dukungan Keluarga dalam Teori *Maternal Role Attainment***

---

Teori MFA menunjukkan bahwa peran sebagai ibu adalah pengalaman belajar yang berkelanjutan dalam usaha untuk mengasah keterampilan baru yang sesuai dengan perkembangan sejak masa kehamilan, serta untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan baru dalam merawat kehamilan dan bayi setelah lahir (Alligood, 2014; (Rholes, 2019). Menurut Mercer asumsi dalam pencapaian peran menjadi ibu (Alligood, 2014), yaitu: 1). Sosialisasi Ibu, menentukan bagaimana ibu mendefinisikan, merasakan, mempersepsikan tentang bayi dan tanggapan bayi pada ibunya, baik saat dalam kehamilan maupun setelah lahir; 2). Tingkat perkembangan dan karakteristik kepribadian bawaan mempengaruhi respon perilakunya; 3). Ayah atau *partner* berperan penting dalam pencapaian peran ibu; 4). Identitas maternal berkembang bersamaan dengan ikatan keibuan dan saling ketergantungan.

Pencapaian Peran Ibu: Model Mercer. *Maternal Role Attainment* yang diperkenalkan oleh Mercer mengacu pada teori Bronfenbrenner yang dikembangkan pada tahun 1979. Teori ini dikenal dengan istilah "lingkaran sarang burung", yang mencakup rangkaian siklus mikrosistem, mesosistem, dan makrosistem (Alligood, 2014) (gambar 1).

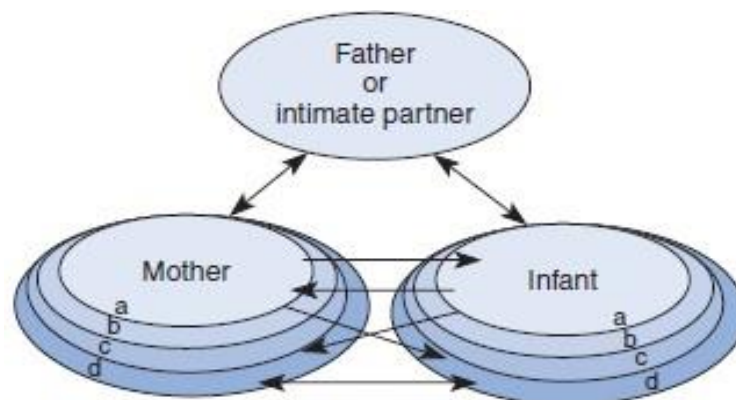
Gambar 1 Model of Maternal Role Attainment (Alligood, 2014)



Model ini dikembangkan Mercer sejalan dengan Bronfenbrenner's, yaitu :

1. Mikrosistem merupakan lingkungan di mana pengasuhan berlangsung, melibatkan berbagai faktor seperti fungsi keluarga, hubungan antara ayah dan ibu, lingkungan sosial, status ekonomi, nilai-nilai dalam keluarga, serta stresor yang ada. Sejak masa kehamilan, seorang bayi terintegrasi dalam sistem keluarga, sehingga mikrosistem ini memberikan pengaruh yang besar terhadap peran pengasuhan ibu. Mercer menunjukkan bahwa peran ayah adalah untuk membantu mengurangi ketegangan. Interaksi antara ayah, ibu, dan bayi sudah dimulai sejak dalam kandungan, yang berkontribusi pada pengasuhan ibu. Lapisan (a) hingga (d) menggambarkan tahapan dalam peran pengasuhan ibu, termasuk berbicara dengan janin, refleks menyentuh (a), dan respon tenang saat berinteraksi dengan janin (b), perilaku interaktif yang konsisten (c) menimbulkan tanggapan janin dengan bergerak (d).

Gambar 2. A Microsistem within the evolving model of maternal role attainment Attainment (Alligood, 2014)



2. Mesosistem mencakup lingkungan umum dalam masyarakat yang mempengaruhi serta berinteraksi dengan individu di mikrosistem. Interaksi dalam mesosistem ini berkontribusi pada perkembangan peran antara ibu dan anak.
3. Makrosistem mengacu pada perkembangan model yang muncul dari budaya tertentu melalui proses transisi budaya yang konsisten. Lingkungan perawatan kesehatan memiliki dampak signifikan terhadap peran pengasuhan ibu..

#### **D. Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga**

---

Faktor-Faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga pada ibu hamil adalah (S. Yoon & Sung, 2021):

1. Tahapan Perkembangan: Setiap rentang usia, mulai dari bayi hingga lansia, memiliki pemahaman dan respons yang berbeda terhadap perubahan kesehatan yang di alami.
2. Pendidikan dan Tingkat Pengetahuan: Keyakinan ibu hamil akan adanya dukungan dipengaruhi oleh variabel intelektual, yang mencakup pengetahuan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman masa lalu. Kemampuan kognitif seseorang membentuk cara berpikir mereka, termasuk kemampuan untuk memahami faktor-faktor yang terkait dengan penyakit serta menggunakan pengetahuan tentang kesehatan untuk menjaga kesejahteraan diri.
3. Faktor Emosional: Emosi turut berperan dalam membentuk keyakinan seseorang mengenai dukungan yang ada dan cara mereka berinteraksi dengannya. Respon terhadap stres yang muncul dalam setiap perubahan hidup sering kali ditunjukkan melalui tanda-tanda fisik, dengan kekhawatiran bahwa penyakit tersebut bisa mengancam hidup mereka. Di sisi lain, individu yang tenang mungkin mengalami respons emosional yang lebih minim ketika menghadapi sakit.
4. Aspek Spiritual: Dimensi spiritual dapat terlihat dalam cara seseorang menjalani kehidupannya. Ini mencakup nilai-nilai dan keyakinan yang mereka anut, hubungan dengan keluarga atau teman, serta kemampuan untuk mencari harapan dan makna dalam hidup.

#### **E. Manfaat Dukungan Keluarga Pada Ibu Hamil**

---

Baik ibu hamil maupun janin mendapatkan manfaat dari dukungan keluarga, terutama pasangan. Dukungan keluarga membantu ibu hamil merasa lebih tenang, nyaman, dan aman. Akhirnya, ibu hamil lebih mudah menyesuaikan diri dengan kondisi mereka saat hamil dan mengurangi ketakutan mereka tentang persalinan. Ibu hamil yang merasa tenang dan nyaman saat hamil akan lebih siap untuk peran ibu, lebih sayang pada janinnya, dan lebih peduli untuk merawat dan menjaga

janinnya. (S. Yoon & Sung, 2021). Janin akan lebih mudah berinteraksi dengan pasangan yang banyak berolahraga bersama. Janin akan terbiasa dengan suara dan sentuhan ayahnya dan ibunya. Dia tidak hanya akan terbiasa berinteraksi dengan suara-suara mereka, tetapi dia juga akan terbiasa dengan suara dan sentuhan tambahan yang didengarkan dan menjaganya. Sebagai respons terhadap stimulasi yang diberikan oleh ibu dan ayahnya, Janin bergerak. Ayah meningkatkan ikatan batinnya dengan janin, yang berdampak pada tumbuh kembang dan hasil kehamilan, mencegah keguguran dan kelahiran bayi premature (Septiani, 2023).

Kesehatan Ibu dan janin juga lebih baik dengan dukungan keluarga. Perawatan antenatal rutin memberikan perhatian dan pengawasan kepada ibu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup, dan berpartisipasi dalam aktivitas yang sehat dan terjaga. Persiapan menyusui juga dapat lebih optimal karena perhatian dan kasih sayang dari suami dapat memicu hipofisis anterior dalam memicu oksitosin yang mempengaruhi hormon prolaktin dalam memproduksi ASI (Rimawati & Suwardianto, 2020).

## **F. Bentuk Dukungan Keluarga Pada Ibu Hamil**

---

Faktor-faktor seperti pendidikan, budaya, dan sosial ekonomi memengaruhi dukungan keluarga. Wawasan dan akses informasi yang penting untuk pengambilan keputusan dipengaruhi oleh pendidikan. Budaya merupakan nilai-nilai kebiasaan yang diterapkan pada lingkungan tempat tinggal, mempengaruhi ketepatan suami memberikan dukungan sesuai dengan yang dibutuhkan selama hamil. Sosial ekonomi berpengaruh pada seluruh jenis dukungan keluarga, dengan sosial ekonomi baik akan lebih mudah mengakses informasi, meningkatkan afektif, pemenuhan materi serta penghargaan pada ibu hamil (Evayanti, 2022).

Bentuk dukungan keluarga, digambarkan sebagai individu atau kelompok yang pengertian, perhatian, peduli, hadir secara fisik, bisa diandalkan ketika dibutuhkan, dan memiliki waktu untuk ibu hamil dan janinnya. Bentuk dukungan keluarga meliputi (Na'im, 2020):

### **1. Dukungan Informasi**

Dukungan dengan pemberian informasi yang mendukung dalam perawatan kehamilan. Dukungan mencakup pemberian nasihat, saran, pengetahuan, dan informasi serta petunjuk. Keluarga (pasangan) terlebih dahulu mencari referensi untuk dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan tentang kehamilan. Dukungan informasi meliputi:

- a. Pasangan memperhatikan perubahan yang terjadi pada kehamilan dan menasehati serta memberi semangat untuk selalu menjaga kesehatannya dengan mengonsumsi makanan bergizi, mengikuti senam hamil atau aktifitas latihan lainnya dan tertib melakukan pemeriksaan kehamilan.

- b. Pasangan mengontrol makanan yang dikonsumsi istri, mendukung untuk mengonsumsi makanan dengan protein tinggi, buah-buahan dan jumlah cairan yang cukup untuk kesehatan kehamilan dan janin.
- c. Pasangan mendukung, mengingatkan dan mendampingi istri dalam minum tablet zat besi setiap harinya untuk meningkatkan sel darah merah dan mencegah anemia.
- d. Pasangan memberikan saran untuk istri tidak melakukan aktifitas fisik atau pekerjaan-pekerjaan yang berat sehingga dapat menyebabkan kelelahan dan mengganggu kesehatan ibu serta janinnya.
- e. Pasangan berkomitmen bersama istri untuk menjauhi rokok baik perokok aktif maupun pasif, serta menjauhi alkohol untuk tumbuh kembang janin yang optimal.
- f. Pasangan mengingatkan istri untuk bersabar menghadapi kehamilan, membimbing dan menemani melaksanakan ibadah untuk meningkatkan kesabaran dan ketenangan.
- g. Pasangan belajar/berlatih membantu merawat bayi baru lahir (memandikan bayi, membersihkan BAK/BAB bayi, menggendong bayi).

## **2. Dukungan Emosi**

Dukungan yang berhubungan dengan rasa tenang, senang, kasih sayang yang mencakup ungkapan empati, kepedulian, kepercayaan, kehadiran untuk mendengarkan dan perhatian dari pasangan pada istri yang sedang hamil maupun calon ayah pada janinnya. Pasangan sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk mencurahkan perasaan, mendengar keluhan yang berpengaruh pada ketenangan emosi karena merasa lebih dihargai, dipedulikan dan disayangi. Ketenangan dan kebahagiaan ibu hamil akan meningkatkan ikatan batin ibu-janin. Pasangan yang rutin mengajak bicara, mencium dan membelai janinnya, maka janin akan mengenali ayah sebagai individu yang dekat dengan dirinya selain ibu. Ikatan batin ibu-janin-ayah berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan janin, kecerdasan mental dan sosial bayi. Ibu hamil yang tenang dan nyaman dapat melahirkan normal dan janin lahir sehat.

Tindakan dukungan emosi pasangan pada ibu hamil dan janin meliputi:

- a. Rutin menanyakan perkembangan dan aktifitas menjaga kehamilan
- b. Berdiskusi tentang perawatan kehamilan serta persiapan persalinan
- c. Mengantar dan menemani istri dalam berbagai aktifitas yang dikerjakan, misalnya mendampingi istri melaksanakan pemeriksaan kehamilan dan konsultasi perkembangan kehamilan.
- d. Mendengarkan dan memberi solusi pada keluhan istri, menggunakan kata-kata yang halus.
- e. Memberikan sentuhan/pelukan, pijatan kecil pada punggung secara rutin.

- f. Mencium ibu dan janin, mengungkapkan cinta dan kasih sayang, mengelus dan membelai janin dan mengajak bicara janin setiap hari.
- g. Membacakan cerita janin atau membaca al-qur'an dekat dengan istri dan janinnya.
- h. Berdo'a dan ibadah bersama dengan istri.

### **3. Dukungan Instrumen/materi**

Dukungan yang bersifat nyata dalam bentuk materi, waktu atau tindakan untuk meringankan ibu hamil. Suami harus memahami bahwa dengan kondisi kehamilan, tempat bergantung utama yang dibutuhkan adalah dari suami.

Dukungan materi yang diperlukan pada masa kehamilan meliputi:

- a. Membantu ibu melaksanakan pekerjaan rumah tangga dan tugas dalam pekerjaan istri yang bekerja.
- b. Menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil yang mencukupi.
- c. Menyediakan sarana transportasi yang aman atau mengantarkan pada setiap kegiatan istri keluar rumah.
- d. Menyiapkan tabungan untuk pemeriksaan kehamilan dan persiapan persalinan.

### **4. Dukungan Penilaian/Penghargaan**

Merupakan motivasi yang diberikan pasangan kepada ibu hamil. Dukungan ini merupakan eksperimen yang dapat berupa persetujuan maupun penilaian positif pada ide-ide maupun harapan positif ibu hamil. Dukungan penghargaan diberikan melalui pujian pada setiap kemajuan proses adaptasi kehamilan dan perkembangan kehamilan istri yang dapat meningkatkan harga dirinya.

Memberikan umpan balik positif kepada ibu hamil tentang kehamilannya, perkembangan kehamilan dan perawatan kehamilan yang telah dilakukan akan berdampak pada emosi. Ibu hamil akan merasa dihargai, diterima dan diperhatikan sehingga akan selalu berupaya menjaga kehamilan yang sehat sampai dilahirkan.

Dukungan penghargaan yang perlu diberikan pasangan antara lain:

- a. Mengucapkan terimakasih atas kehamilan istri.
- b. Memberikan pujian, ungkapan sayang dengan seluruh kemajuan tindakan istri dalam menjaga kehamilan.
- c. Memberikan hadiah pada istri pada kemajuan adaptasi dan perkembangan kehamilan dengan sesuatu yang disukai istri yang tidak mengganggu kehamilan, misalnya: membelikan makanan kesukaan, barang yang sangat diinginkan istrinya.

d. Senantiasa mendo'akan untuk kesehatan istri dan janinnya.

Kesiapsiagaan pasangan, yang ditunjang oleh pengetahuan yang baik serta perhatian dan kasih sayang, dapat menciptakan suasana emosional yang stabil dan bahagia bagi ibu hamil. Dengan dukungan seperti ini, ibu akan merasa lebih tenang, aman, dan nyaman, sehingga termotivasi untuk menjaga kesehatan, berpikir positif, dan rutin menjalani pemeriksaan kehamilan. Selain itu, stimulasi dari ayah kepada janin melalui komunikasi dan sentuhan dapat memberikan rasa tenang bagi janin serta membangun ikatan emosional yang kuat. Suara dan sentuhan yang dirasakan oleh janin turut berkontribusi pada perkembangan kognitif, emosional, dan sosialnya. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan suami dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi ibu hamil dan janin, yang berujung pada kesehatan ibu dan bayi hingga saat persalinan (Purwati et al., 2023).

#### **G. *Evidenced Based* Dukungan Keluarga Pada Ibu Hamil**

---

Pentingnya dukungan keluarga pada ibu hamil telah dibuktikan dengan berbagai penelitian internasional dan nasional sebagai berikut:

1. *The Relation Between Husband Support to Pregnant Women Participation in Pregnancy Classes* (Laksmi, 2023).

Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara dukungan suami dan partisipasi ibu hamil dalam mengikuti kelas ibu hamil. Ibu hamil yang mendapatkan dukungan dari suaminya memiliki peluang berpartisipasi yang 6,22 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak mendapatkan dukungan tersebut. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya meningkatkan peran suami melalui dorongan dari tenaga kesehatan agar lebih aktif dalam mengikuti kelas ibu hamil. Teori Lawrence Green menyatakan bahwa dukungan adalah salah satu faktor kunci yang dapat memengaruhi perilaku seseorang.

Dukungan sosial memiliki peranan penting sebagai pendorong bagi individu untuk berpartisipasi dan berperilaku sehat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diani & Susilawati, (2023) Ibu yang berpartisipasi kurang dalam kelas ibu hamil sebagian besar berasal dari kelompok yang menerima dukungan rendah dari suami atau keluarga, dengan persentase mencapai 63,6%. Sebaliknya, ibu yang berpartisipasi aktif dalam kelas ibu hamil cenderung lebih banyak berasal dari kelompok yang mendapatkan dukungan yang baik dari suami atau keluarga, yaitu sebesar 60,7%, dibandingkan dengan ibu hamil yang mendapatkan dukungan kurang. Dukungan pasangan akan meningkatkan kesiapan ibu hamil dalam menghadapi kehamilannya, dan proses persalinan hingga ke persiapan menjadi orang tua. Keterlibatan suami sejak awal masa



kehamilan akan mempermudah dan meringankan ibu dalam menjalani dan mengatasi berbagai perubahan yang terjadi pada tubuh ibu akibat hadirnya janin di dalam perut. Sejalan dengan program ini diharapkan minimal satu kali pertemuan ibu hamil didampingi suami/keluarga. Hal ini dimaksudkan agar kesehatan ibu selama hamil, bersalin, nifas, termasuk kesehatan bayi yang baru dilahirkannya dan kebutuhan akan KB pasca persalinan menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh keluarga (Diani & Susilawati, 2023).

Dukungan dari keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kesehatan ibu. Keterlibatan anggota keluarga, terutama pasangan atau suami, dapat mendorong perubahan perilaku serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Meskipun informasi kesehatan lebih banyak diperoleh dari petugas kesehatan, keluarga, dan masyarakat, suami memegang peran utama dalam bentuk dukungan sosial untuk ibu hamil. Oleh karena itu, peran suami tidak hanya sebatas sebagai pengambil keputusan, tetapi juga diharapkan selalu siaga dan memberikan perhatian terhadap kesehatan serta keselamatan ibu hamil (Yusmaharani, 2018). Dukungan suami sangat membantu dalam pembentukan perilaku kesehatan ibu karena ibu hamil akan cenderung menuruti apa yang disarankan oleh suaminya, sehingga dukungan sosial suami menjadi faktor berpengaruh besar hubungannya dengan partisipasi ibu dalam kelas ibu hamil (Sebuah et al., 2018).

Menurut hasil penelitian Zefanya & Suryadi, (2021) Dukungan sosial bagi ibu hamil berasal dari tiga pihak, yaitu suami, keluarga, dan tenaga kesehatan. Namun, dukungan yang paling signifikan datang dari suami. Di Indonesia, suami memiliki peran yang dominan dalam keluarga, terutama dalam pengambilan keputusan terkait berbagai hal, termasuk kesehatan reproduksi. Kurangnya kesadaran pria tentang kesehatan reproduksi tidak muncul begitu saja; salah satu penyebabnya adalah faktor budaya yang menganggap pria sebagai pemegang kekuasaan dalam pengambilan keputusan, sementara wanita atau istri dianggap sebagai pendamping. Akibatnya, wanita sering kali tidak memiliki kebebasan untuk menentukan keinginannya sendiri. Dalam konteks kesehatan reproduksi, suami seharusnya berfungsi sebagai mitra untuk mencapai kesehatan yang lebih baik. Dukungan serta peran suami selama masa kehamilan terbukti memberikan manfaat yang besar, antara lain untuk meningkatkan kesiapan ibu hamil menghadapi persalinan dan mendukung keberhasilan proses menyusui.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa 42,9% responden yang mendapatkan dukungan dari suami tidak mengikuti kelas ibu hamil, sementara 17,6% responden yang tidak menerima dukungan suami tetap aktif berpartisipasi dalam kelas tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengaruh dua faktor: faktor eksternal seperti dukungan suami, dan faktor internal yang

merupakan modal utama dalam membentuk perilaku seseorang. Faktor internal yang dimaksud adalah motivasi yang dimiliki oleh ibu hamil itu sendiri. Individu dengan motivasi tinggi cenderung akan menunjukkan perilaku positif meskipun tanpa dukungan eksternal. Namun, jika dukungan eksternal ada, hal tersebut akan semakin memperkuat motivasi tersebut. Oleh karena itu, sinergi yang baik antara motivasi ibu hamil dan dukungan dari suami dapat mengoptimalkan perilaku ibu hamil menuju arah yang lebih positif (Diani & Susilawati, 2023).

## 2. *Husband's Support, Anxiety and Maternal-Fetal Attachment in Pregnant Women: A Scoping Review* (Purwati et al., 2023)

Hasil scoping review yang dilakukan pada 12 artikel penelitian nasional dan internasional tahun 2017-2021 dihasilkan temuan bahwa kecemasan prenatal dan MFA dikaitkan dengan peran dukungan sosial keluarga dan secara khusus yaitu dari suami. Dukungan yang diberikan oleh suami merupakan sumber daya vital untuk mengatasi kecemasan. Suami berperan penting dalam menjaga emosi positif pada ibu hamil. Dukungan emosional suami mempengaruhi ketenangan batin dan perasaan senang ibu hamil, sehingga lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan masa kehamilan, menurunkan ketegangan atau kecemasan dan meningkatkan MFA. Dukungan suami yang efektif dapat meningkatkan kesehatan dan hubungan selama masa transisi kehamilan, menghasilkan hubungan psikologis yang nyaman yang mempengaruhi kualitas hubungan ibu-janin (Ramsdell et al., 2020; Doss & Rhoades, 2017; Calkins & Brock, 2022). Penelitian terhadap 285 ibu hamil, 252 (88,4%) yang mendapat dukungan keluarga yang baik terjadi hubungan kelekatan ibu janin yang kuat daripada ibu dengan dukungan keluarga yang kurang baik 33(11,5%) dengan  $P=0,001$  (Hassan & Hassan, 2017).

Dukungan keluarga penting karena ibu hamil membutuhkan orang lain untuk dapat diajak bicara dan membantu pada situasi kehamilan yang sedang dialami. Dukungan sosial merupakan kenyamanan fisik dan psikologis yang diberikan oleh teman, tetangga, tenaga kesehatan maupun keluarga. Dukungan sosial dapat berupa dukungan emosional, penghargaan, instrumental, informasi, dan dukungan kelompok (Pasricha et al., 2021). Dukungan yang diperoleh ibu hamil akan mempengaruhi keamanan, ketenangan sehingga menurunkan resiko dampak buruk psikologis yaitu kecemasan, stress sampai dengan depresi. Dampak positif dukungan sosial yang diberikan kepada ibu hamil adalah penyesuaian terhadap situasi kehamilan dengan berbagai perubahan fisik dan psikologis. Dukungan yang diperoleh ibu hamil akan membuat tenang dan nyaman selama kehamilan, berefek meningkatkan kepedulian ibu pada janinnya. Ibu hamil memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan janin, merawat janinnya dan melaksanakan antenatal care dengan teratur serta aktif mengikuti kelas prenatal yang bermanfaat dalam menjaga kehamilan, kesehatan janin sampai dengan melahirkan bayi sehat (Pasricha et al., 2021). Hasil penelitian 5 artikel menunjukkan bukti yang sejalan

dengan pentingnya dukungan keluarga pada ibu hamil, sejak trimester I sampai dengan trimester III, baik pada kehamilan normal, beresiko maupun kehamilan karena *Assisted Reproductive Technology* (ART) (Ranjbar et al., 2021; Hopkins et al., 2018). Dukungan keluarga yang didapatkan ibu hamil mempengaruhi tingkat kecemasan dan stress lebih rendah dan berdampak pada maternal fetal attachment yang tinggi dan hasil kelahiran bayi yang sehat. Dukungan sosial walaupun dapat diperoleh dari teman, kerabat, tenaga kesehatan, keluarga, namun dukungan yang paling dominan mempengaruhi pada keamanan dan kenyamanan ibu hamil lebih utama berasal dari pasangan/suami (Ertmann et al., 2021).

Dukungan keluarga merupakan dukungan sosial, namun berasal dari kerabat yang memiliki ikatan darah seperti orangtua, mertua, saudara kandung maupun keluarga inti yang meliputi suami dan anak. Dukungan yang diberikan merupakan bukti kasih sayang, perhatian, dan keinginan untuk mendengarkan keluh kesah. Dukungan keluarga berperan sebagai mediator untuk mengurangi penurunan MFA akibat kecemasan dan depresi. Ikatan yang dirasakan ibu hamil dengan orangtua sebagai sumber dukungan merupakan pengalaman emosional dari orangtuanya sejak masa bayi, anak hingga remaja sehingga merasa dekat dan nyaman dekat dengan orangtua/keluarga (S.-H. Yoon & Sung, 2021b).

Dukungan keluarga mempunyai andil yang besar dalam menentukan status kesehatan ibu hamil. Keluarga yang mengharapkan kehamilan menunjukkan dukungan dan perhatian besar pada ibu hamil. Ibu hamil lebih percaya diri, bahagia, siap dalam menjalani kehamilan, persalinan dan nifas. Dukungan keluarga mempengaruhi tingkat kecemasan ibu dalam menjalani masa kehamilan dan berdampak pada MFA (Bäckström et al., 2017; Yoon & Sung, 2021b). Dukungan keluarga meningkatkan rasa aman nyaman, mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepedulian ibu pada janin. Pada penelitian sejalan Wang et al., (2021) menyebutkan, dukungan keluarga dibutuhkan ibu hamil dalam menghadapi kehamilan sampai kelahiran bayi, mengurangi stressor ibu hamil dan berdampak pada respon ibu hamil dalam menilai situasi yang sedang dialami. Ibu hamil merasa aman dan nyaman karena terdapat keluarga yang siap membantu sehingga mengubah respon terhadap sumber kecemasan dengan mencurahkan kepada keluarga tentang situasi yang dialaminya.

Dukungan suami mencakup komunikasi verbal dan non-verbal, saran, serta bantuan yang nyata, yang semuanya diberikan kepada ibu hamil. Bentuk dukungan ini merupakan ungkapan perhatian dan kasih sayang yang dilakukan secara fisik dan psikologis, sebagai orang terdekat pada ibu hamil. Peran suami sangat signifikan dalam menentukan kesehatan ibu selama masa kehamilan (Fielding-Miller et al., 2022). Dukungan suami yang baik dapat memberikan motivasi pada ibu untuk memeriksakan kehamilannya. Suami dapat membantu tugas istri, memenuhi kebutuhan istri selama hamil, mengantarkan periksa,

menemani istri melakukan kegiatan latihan selama kehamilan sehingga pertumbuhan dan perkembangan janin makin baik (Doss, 2010; Bäckström et al., 2017). Hasil penelitian sejalan bahwa ibu hamil dengan dukungan suami yang baik, semakin menunjukkan MFA yang tinggi, waktu persalinan lebih singkat dan bayi lahir normal (Ross et al., 2018).

3. *Perceptions of primigravida and their husbands regarding the need for maternal-fetal attachment stimulation* (Purwati, et al., 2024).

Hasil penelitian ini menunjukkan dukungan suami merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi rasa aman dan nyaman ibu hamil. Suami merupakan sumber dukungan terdekat secara emosional, mampu memberikan ketenangan, rasa aman, dan rasa nyaman pada ibu hamil yang berdampak pada janin, merangsang tumbuh kembang yang optimal (Smorti et al., 2020; Zhang et al., 2021). Partisipan yang merupakan ibu hamil beserta suami menyatakan dukungan yang diberikan oleh suami, namun terbatas pada pemenuhan kebutuhan kehamilan, menemani jalan-jalan, melakukan pemeriksaan namun menunggu di luar. Rasa peduli terhadap janin diungkapkan melalui ciuman, belaian, dan berbicara kepada janin secara rutin. Ibu hamil beserta suami perlu memahami pentingnya dukungan suami terhadap ibu hamil dan janinnya.

Dukungan sosial, khususnya dari suami, dapat mengurangi intensitas stres terkait kehamilan, sehingga meningkatkan energi ibu untuk berinvestasi pada kesejahteraan emosionalnya serta membangun dan meningkatkan MFA. Pengalaman keterikatan yang diperoleh sebelum kehamilan merangsang aktivasi model kerja internal dan diwujudkan dalam bentuk respons emosional dan perilaku terhadap kehamilan (Zhang et al., 2021). Temuan sebelumnya mengenai dukungan sosial menunjukkan bahwa peningkatan dukungan sosial, terutama dukungan suami, berkorelasi signifikan dengan skor MFA yang lebih tinggi ( $p=0,001$ ) (Wallace et al., 2023).

4. *Participant analysis of the need for prenatal attachment education packages* (Purwati, et al., 2024).

Penelitian studi kualitatif *focus group discussion* dilakukan pada delapan partisipan tenaga kesehatan yang bertugas pada delapan fasilitas kesehatan dasar di Bantul Yogyakarta Indonesia. Suami merupakan sumber dukungan utama bagi ibu hamil, namun kelas suami belum terlaksana secara optimal, dan belum ada panduan karena kesulitan untuk melibatkan suami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cinta suami dapat menciptakan rasa aman dan nyaman pada ibu, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan MFA, sehingga berkontribusi positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan fisik dan emosional ibu dan janin (Grundström et al., 2022). Diperlukan inovasi dalam panduan, media, dan teknik penyelenggaraan kelas suami. Para suami yang bekerja dapat

diberikan metode dan media pembelajaran yang mudah diakses, seperti video kelas dukungan suami yang mudah ditonton dan diikuti di WhatsApp.

Penelitian oleh Al Owaifeer et al., (2018) menyatakan bahwa video pembelajaran dapat digunakan berulang kali, memperlihatkan realitas gerakan, suara, dan tempat, sehingga memengaruhi emosi untuk menyampaikan pesan secara efektif dan mencapai tujuan promosi kesehatan. Hasil penelitian terdahulu tentang penggunaan WhatsApp dalam pendidikan menunjukkan bahwa WhatsApp merupakan media yang efektif untuk memotivasi dan menyebarkan informasi kesehatan yang memerlukan pengulangan, serta efektif mencapai tujuan promosi kesehatan dengan  $p < 0,05$  (Grundström et al., 2022). Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan program pendidikan dukungan suami diperlukan sebagai komponen keempat dalam paket pendidikan keterikatan prenatal.

## **H. Penutup**

---

Dukungan dari keluarga memainkan peranan penting dalam menentukan kesehatan ibu hamil. Suami berfungsi sebagai sumber dukungan utama bagi ibu hamil, sementara keluarga dapat memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, seperti informasi, perhatian emosional, bantuan materi, dan penghargaan. Keterlibatan keluarga selama masa kehamilan berfungsi sebagai penghubung antara kecemasan, faktor-faktor stres, dan hasil kelahiran. Dengan demikian, dukungan keluarga sangat berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan ibu hamil, yang memungkinkan perawatan kehamilan yang optimal demi kesehatan ibu dan bayi. Diperlukan pembinaan pada keluarga sehingga dapat memberikan dukungan yang optimal pada ibu hamil.

## Referensi

- Al Owaifeer, A. M., Alrefaie, S. M., Alsawah, Z. M., Al Taisan, A. A., Mousa, A., & Ahmad, S. I. (2018). The effect of a short animated educational video on knowledge among glaucoma patients. *Clinical Ophthalmology*, 12, 805–810. <https://doi.org/10.2147/OPTH.S160684>
- Alligood, M. R. (2014). Nursing Theorists and Their Work (Maternal Role Attainment-Becoming a Mother). In *Elsevier* (Vol. 8). <https://doi.org/10.5172/conu.2007.24.1.106a>
- Bäckström, C., Thorstensson, S., Mårtensson, L. B., Grimming, R., Nyblin, Y., & Golsäter, M. (2017). "To be able to support her, I must feel calm and safe": Pregnant women's partners perceptions of professional support during pregnancy. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 17(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12884-017-1411-8>
- Bamalan, O. A., Moore, M. J., & Khalili, Y. Al. (2022). *Physiology, Serotonin*. StatPearls Publishing LLC. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31424752/>
- Bappeda DIY. (2021). *Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta: Pertumbuhan Penduduk* (pp. 5–6). Bappeda DIY. [http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data\\_dasar/index/308-pertumbuhan-penduduk](http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/308-pertumbuhan-penduduk)
- Borroto-Escuela, D. O., Ambrogini, P., Chruścicka, B., Lindskog, M., Crespo-Ramirez, M., Hernández-Mondragón, J. C., de la Mora, M. P., Schellekens, H., & Fuxe, K. (2021). The role of central serotonin neurons and 5-HT heteroreceptor complexes in the pathophysiology of depression: A historical perspective and future prospects. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(4), 1–13. <https://doi.org/10.3390/ijms22041927>
- Calkins, F. C., & Brock, R. L. (2022). Attachment anxiety and avoidance predict postnatal partner support through impaired affective communication. *Journal of Marriage and Family*, 84(2), 515–532. <https://doi.org/10.1111/jomf.12806>
- Diani, L. P. P., & Susilawati, L. K. P. A. (2023). Pengaruh Dukungan Suami terhadap Istri yang Mengalami Kecemasan pada Kehamilan Trimester Ketiga di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Psikologi Udayana*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.24843/jpu.2013.v01.i01.p01>
- Doss, B. D. (2010). The Effect of the Transition to Parenthood on Relationship Quality: An Eight-Year Prospective Study. *Journal of Personality*, 96(3), 601–619. <https://doi.org/10.1037/a0013969>
- Doss, B. D., & Rhoades, G. K. (2017). The transition to parenthood: impact on couples' romantic relationships. *Current Opinion in Psychology*, 13, 25–28. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.04.003>
- Ertmann, R. K., Bang, C. W., Kriegbaum, M., Væver, M. S., Kragstrup, J., Siersma, V., Wilson, P., Lutterodt, M. C., & Smith-Nielsen, J. (2021). What factors are most

- important for the development of the maternal-fetal relationship? A prospective study among pregnant women in Danish general practice. *BMC Psychology*, 9(1), 2. <https://doi.org/10.1186/s40359-020-00499-x>
- Evayanti, Y. (2022). Hubungan Pengetahuan Ibu dan Dukungan Suami pada Ibu Hamil Terhadap Keteraturan Kunjungan Antenatal Care (ANC) di Puskesmas Wates Lampung Tengah Tahun 2015. *Jurnal Kebidanan. JKM (Jurnal Kebidanan Malahayati)*, 7(2), 81–90. <http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/kebidanan/article/view/550/484>
- Fielding-Miller, R., Barker, K., & Wagman, J. (2022). Relative Risk of Intimate Partner Violence According to Access to Instrumental Social Support Among Pregnant Women in Eswatini Whose Partners Do and Do Not Drink Alcohol. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(13–14), NP12671–NP12684. <https://doi.org/10.1177/0886260521993925>
- Friedman. (2013). *Keperawatan Keluarga*. Gosyen Publishing.
- Goldstein, J. T., Hartman, S. G., Meunier, M. R., Panchal, B., Pecci, C. C., Zink, N. M., & Shields, S. G. (2018). Supporting family physician maternity care providers. *Family Medicine*, 50(9). <https://doi.org/10.22454/FamMed.2018.325322>
- Grundström, H., Malmquist, A., Nieminen, K., & Alehagen, S. (2022). Supporting women's reproductive capabilities in the context of childbirth: Empirical validation of a midwifery theory synthesis. *Midwifery*, 110, 103320. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.midw.2022.103320>
- Hassan, N. M. M., & Hassan, F. M. A. E. (2017). Predictors of Maternal Fetal Attachment among Pregnant Women. *IOSR Journal of Nursing and Health Science*, 6(1), 95–106. <https://doi.org/10.9790/1959-06010695106>
- Hopkins, J., Miller, J. L., Butler, K., Gibson, L., Hedrick, L., & Boyle, D. A. (2018). The relation between social support, anxiety and distress symptoms and maternal fetal attachment. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 36(4), 381–392. <https://doi.org/10.1080/02646838.2018.1466385>
- Laksmi, N. P. C. (2023). Relationship between Husband's Social Support and Participation in Pregnant Women Class in Denpasar City in 2019. *Journal of Health Science and Medical Therapy*, 2(01), 63–69. <https://doi.org/10.59653/jhsmt.v2i01.444>
- Maharlouei, N. (2020). The Importance of Social Support During Pregnancy. *Women's Health Bulletin*, 3(1). <https://doi.org/10.17795/whb-34991>
- Maziyatul, N., Fahmi, D., & Febri, A. (2020). Perkembangan kognitif, fisik, dan emosi sosial pada masa prenatal. *Wisdom: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 01(02), 85–106.
- Na'im, N. J. (2020). *Relation Family Support with Level of Anxiety Primipara mom (mother) Facing Childbirth in Health Society of Pamulang South Districk of*

*Tangerang* (Vol. 44, Issue August).

- Pasricha, M., Kochhar, S., Shah, A., Bhatia, A., Lucia, V., & Rosa, L. (2021). *Sense of Coherence , Social Support , Maternal-Fetal Attachment , and Antenatal Mental Health : A Survey of Expecting Mothers in Urban India*. 2(September), 1–8. <https://doi.org/10.3389/fgwh.2021.714182>
- Purwati, Y., Pramono, N., Hakimi, M., & Anggorowati, A. (2023). Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan Husband ' s Support, Anxiety and Maternal-Fetal Attachment in Pregnant Women : A Scoping Review. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(2), 325–336. <https://doi.org/10.30604/jika.v8i2.1828>
- Purwati, Y., Pramono, N., Hakimi, M., Sudarmiati, S., & Anggorowati. (2024). Perceptions of primigravida and their husbands regarding the need for maternal-fetal attachment stimulation. *International Journal of Public Health Science*, 13(3), 1230–1240. <https://doi.org/10.11591/ijphs.v13i3.23913>
- Purwati, Y., Pramono, N., Hakimi, M., Suwandono, A., Kristina, T. N., & Anggorowati, A. (2024). Participant analysis of the need for prenatal attachment education packages. *Kontak*, 26(3), 309–316. <https://doi.org/10.32725/kont.2024.034>
- Ramsdell, E. L., Franz, M., & Brock, R. L. (2020). A Multifaceted and Dyadic Examination of Intimate Relationship Quality during Pregnancy: Implications for Global Relationship Satisfaction. *Family Process*, 59(2), 556–570. <https://doi.org/10.1111/FAMP.12424>
- Ranjbar, F., Catja Warmelink Comma Comma, J., Mousavi, R., & Gharacheh, M. (2021). Maternal-fetal attachment and anxiety in pregnant women who conceived through assisted reproductive technology: A longitudinal study. *International Journal of Reproductive Biomedicine*, 19(12), 1075–1084. <https://doi.org/10.18502/ijrm.v19i12.10058>
- Rholes, J. A. S. & W. S. (2019). Adult Attachment Orientations and Well-Being during the Transition to Parenthood. *Curr Opin Psychol*. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2018.02.019>
- Rimawati, R., & Suwardianto, H. (2020). Family Support in Management of Lactation Management in Mother With Children During Pandemic Covid-19. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 9(2), 694–699. <https://doi.org/10.30994/sjik.v9i2.364>
- Ross, L. E., Goldberg, A. E., Tarasoff, L. A., & Guo, C. (2018). Perceptions of partner support among pregnant plurisexual women: A qualitative study. *Sexual and Relationship Therapy*, 33(1–2), 59–78. <https://doi.org/10.1080/14681994.2017.1419562>
- Sebuah, J. H., Sebuah, J. L. M., Sebuah, K. B., Sebuah, L. G., Hedrick, L., & Anne, D. (2018). *Hubungan antara dukungan sosial , kecemasan dan gejala tertekan dan perlekatan janin pada ibu*. 36, 381–393.



- Septiani, R. (2023). *Pengetahuan, Sikap Ibu Hamil Dan Dukungan Suami Dengan Keikutsertaan Ibu Hamil Dalam Kelas Ibu Hamil Di Puskesmas Kota Metro Lampung*.
- Shah, M. K., Gee, R. E., & Theall, K. P. (2014). Partner support and impact on birth outcomes among teen pregnancies in the United States. *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology*, 27(1), 14–19. <https://doi.org/10.1016/j.jpag.2013.08.002>
- Smorti, M., Ponti, L., Simoncini, T., Pancetti, F., Mauri, G., & Gemignani, A. (2020). Psychological factors and maternal-fetal attachment in relation to epidural choice. *Midwifery*, 88. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102762>
- United Nations Development Programme. (2020). *Sustainable Development Goals* (pp. 68–70). <https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf>
- Wallace, E. R., Buth, E., Szpiro, A. A., Ni, Y., Loftus, C. T., Masterson, E., Day, D. B., Sun, B. Z., Sullivan, A., Barrett, E., Nguyen, R. H. N., Robinson, M., Kannan, K., Mason, A., Sathyanarayana, S., LeWinn, K. Z., Bush, N. R., & Karr, C. J. (2023). Prenatal exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons is not associated with behavior problems in preschool and early school-aged children: A prospective multi-cohort study. *Environmental Research*, 216, 114759. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.114759>
- Wallace, K., & Araj, S. (2020). An Overview of Maternal Anxiety During Pregnancy and the Post-Partum Period. *Journal of Mental Health & Clinical Psychology*, 4(4), 47–56. <https://doi.org/10.29245/2578-2959/2020/4.1221>
- Wang, Y.-N., Yuan, Z.-J., Leng, W.-C., Xia, L.-Y., Wang, R.-X., Li, Z.-Z., Zhou, Y.-J., & Zhang, X.-Y. (2021). Role of perceived family support in psychological distress for pregnant women during the COVID-19 pandemic. *World Journal of Psychiatry*, 11(7), 365–374. <https://doi.org/10.5498/wjp.v11.i7.365>
- Yoon, S.-H., & Sung, M.-H. (2021a). Does family support mediate the effect of anxiety and depression on maternal-fetal attachment in high-risk pregnant women admitted to the maternal-fetal intensive care unit? *Korean Journal of Women Health Nursing*, 27(2), 104–112. <https://doi.org/10.4069/kjwhn.2021.05.14>
- Yoon, S.-H., & Sung, M.-H. (2021b). Does family support mediate the effect of anxiety and depression on maternal-fetal attachment in high-risk pregnant women admitted to the maternal-fetal intensive care unit? *Korean Journal of Women Health Nursing*, 27(2), 104–112. <https://doi.org/10.4069/kjwhn.2021.05.14>
- Yoon, S., & Sung, M. (2021). *Artikel asli Apakah dukungan keluarga memediasi efek kecemasan dan depresi terhadap keterikatan ibu-janin pada ibu hamil risiko tinggi yang dirawat di unit perawatan intensif ibu-janin? Metode*

*Pernyataan etika : Studi ini disetujui oleh Institutional. 27(2), 104–112.*

- Yuan, L., Gu, Z., Peng, H., & Zhao, L. (2018). *A Paternal-fetal Attachment Pilot Intervention on Mental Health for Pregnant Mothers. 16(1), 250022.* <https://doi.org/10.14704/nq.2018.16.1.1162>
- Yusmahanani, Y. (2018). Hubungan Dukungan Suami dengan Pemanfaatan Kelas Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Harapan Raya Pekanbaru. *KESMARS: Jurnal Kesehatan Masyarakat, Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit, 1(1), 1–5.* <https://doi.org/10.31539/kesmars.v1i1.149>
- Zefanya, C., & Suryadi, D. (2021). The Effect of Social Support on Pregnancy-Related Anxiety in First Trimester Expecting Mothers. *Proceedings of the International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities (ICEBSH 2021), 570(Icebsh), 540–547.* <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210805.085>
- Zhang, L., Wang, L., Cui, S., Yuan, Q., Huang, C., & Zhou, X. (2021). Prenatal Depression in Women in the Third Trimester: Prevalence, Predictive Factors, and Relationship With Maternal-Fetal Attachment. *Frontiers in Public Health, 8.* <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.602005>

## Glosarium

### A

AKI : Angka kematian Ibu

AKB: Angka Kematian Bayi

*ART; Assisted Reproductive Technology* (Teknologi yang digunakan untuk membantu kesehatan reproduksi)

---

### B

BBLR : Berat badan Lahir Rendah

---

### C

CI : Confident Interval: rentang nilai yang digunakan untuk mengestimasi nilai parameter populasi yang tidak diketahui.

---

### M

MFA: Maternal-Fetal Attachment; ikatan batin ibu dan janin

*MRA: Maternal Role Attainment (Peran menjadi Ibu)*

---

### N

Neurotransmitter: zat kimia yang mengatur komunikasi antar neuron yang berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh.

---

### O

OR : Odds Ratio: perbandingan antara kemungkinan terjadinya suatu kejadian pada kelompok yang memiliki karakteristik tertentu dibandingkan dengan kelompok yang tidak memiliki karakteristik tersebut.

---

### S

SDGs : Sustainable Development Goals

Serotonin : neurotransmitter yang berperan penting dalam mengatur mood dan emosi, pola tidur, nafsu makan, stress, nyeri.

---

# Profil Penulis



## **Yuliana Dafroyati, S.Kep., Ns, M.Sc.**

Lahir di Damer 18 Februari 19972. Lulus Akademi Keperawatan PEMDA Kupang tahun 1996, melanjutkan pendidikan Keperawatan di Universitas Airlangga Surabaya dengan perolehan gelar (S.Kep) tahun 2004 dan (Ns) pada tahun 2005. Pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada dengan peminatan Maternal Perinatal, lulus tahun 2010 dengan gelar(MSc). Riwayat pekerjaan : pada tahun 1997-2021 bekerja di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi NTT bidang program Diklat. Tahun 2021 pindah ke Poltekkes Kemenkes Kupang-sekarang dan saat ini aktif sebagai Dosen Pada Prodi Diploma Tiga Keperawatan Kupang dan juga mengajar di program Pendidikan Profesi Ners Poltekkes Kemenkes Kupang. Sebagai Dosen aktif dalam kegiatan Tri Dharma PT yaitu mengajar mata kuliah Maternitas, Dokumentasi Keperawatan, Komunikasi terapeutik dan juga Riset Keperawatan. Selain mengajar juga aktif meneliti serta publikasi dalam bentuk buku ajar, monograf, jurnal (nasional dan Internasional). Kegiatan pengabdian masyarakat aktif dalam kegiatan pendidikan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi profesi yang didukung dengan kepemilikan sertifikat sebagai pengendali pelatihan (TPP) dan sebaga tenaga pelatih kesehatan (TPK). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [yulianambendon@gmail.com](mailto:yulianambendon@gmail.com)



## **Vivi Dwi Putri, S.ST., M.Kes.**

Lahir di Jambi, 18 Se\$pte\$mbe\$r 1991. Pe\$ndidikan tinggi yang te\$lah dite\$mpuh ole\$h pe\$nullis yaitu je\$njang Diploma III pada Program Studi Ke\$bidanan, Akade\$mia Ke\$bidanan Budi Mulia Jambi tahun 2012. Untuk je\$njang Diploma IV pada Program Studi Bidan Pe\$ndidik, STIKE\$S Kharisma Karawang tahun 2013. Ke\$mudian me\$lanjutkan pe\$ndidikan S2 pada Unive\$rsitas Re\$spati Indone\$sia dan lulus tahun pada tahun 2015. Saat ini be\$rdomisili di Kota Pale\$mbang dan juga status saya se\$karang me\$rupakan te\$naga pe\$ndidik di salah satu kampus swasta yang ada di Kota Pale\$mbang dan me\$ngampu mata kuliah Psikologi Ke\$hamilan, Pe\$rsalinan dan Nifas. Buku ini me\$rupakan salah satu tugas saya dalam me\$njalkan Tri Dharma Pe\$rguruan Tinggi untuk me\$mbantu me\$nge\$mbangkan bahan ajar se\$suai de\$ngan mata kuliah yang di ampuh pada

prodi Pendidikan dan Profesi Bidan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [vividwip@gmail.com](mailto:vividwip@gmail.com)

Motto: "jangan merisaukan apa yang belum terjadi, tetapi risaukanlah apa yang belum di syukuri"



**Frani Mariana, SST., M. Keb.**

Lahir di Sebapo, 22 September 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kebidanan di Stikes Aisyiyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Aisyiyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2019. Saat ini penulis bekerja di Universitas Sari Mulia mengampu mata kuliah Kebidanan I, Anatomi dan Fisiologi Manusia, Psikologi dalam Praktik Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar yang berfokus pada tema kesehatan ibu dan anak. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [franimariana22@gmail.com](mailto:franimariana22@gmail.com)



**Fatihah Wari Nurjanah, M.Tr.Keb.**

Lahir di Sukoharjo, 29 Desember 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan, Universitas Gadjah Mada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Poltekkes Kemenkes Semarang dan lulus tahun pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2023 di Akbid Giri Satria Wonogiri sebagai dosen kebidanan. Saat ini penulis bekerja di Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia mengampu mata kuliah ISBD, Konsep Kebidanan, Askeb Hamil, dll. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [fatihahwn@gmail.com](mailto:fatihahwn@gmail.com)  
Motto: "Tidak menyerah dalam melewati rintangan kehidupan"



**Dr. Yuni Purwati, S.Kep., Ns., M.Kep.**

Lahir di Klaten, 11 Juni 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Magister Keperawatan FKMK Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997 setelah lulus dari DIII Keperawatan bekerja sebagai

perawat pelaksana keperawatan di RSKB Diponegoro 21 Klaten, tahun 1999 mengawali karir di dunia pendidikan sebagai asisten dosen di AKPER Wiyata Husada. Sejak tahun 2006 menjadi dosen di Universitas Aisyiyah Yogyakarta hingga sekarang, mengampu mata kuliah keperawatan maternitas dan metodologi keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, workshop, seminar, organisasi seminat dan kegiatan persyarikatan Muhammadiyah-Aisyiyah dalam penelitian serta pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail [yunipurwati@unisayogya.ac.id](mailto:yunipurwati@unisayogya.ac.id)  
Motto: "Do everithing with a good heart and expect nothing in return and you will never be disappointed"

# Sinopsis

Buku Referensi "**Pentingnya Kesehatan Mental dalam Kehamilan**" hadir sebagai jawaban atas kebutuhan informasi tentang aspek psikologis yang sering terabaikan selama masa kehamilan. Kehamilan adalah periode yang penuh perubahan fisik dan emosional, yang bila tidak ditangani dengan tepat, dapat memicu berbagai gangguan mental seperti depresi, kecemasan, hingga stres berkepanjangan. Melalui buku ini, para penulis secara komprehensif mengupas berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ibu hamil, termasuk perubahan hormon, dukungan keluarga, status ekonomi, serta pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh ibu hamil.

Secara rinci, buku ini menjelaskan pentingnya dukungan emosional selama masa kehamilan, baik dari pasangan, keluarga, maupun lingkungan sosial. Dukungan tersebut terbukti efektif dalam menurunkan risiko gangguan mental, meningkatkan kesejahteraan emosional ibu hamil, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang janin. Selain itu, berbagai strategi praktis seperti aktivitas fisik, prenatal yoga, meditasi, dan teknik relaksasi juga dibahas secara mendalam sebagai upaya menjaga keseimbangan mental dan emosional ibu selama masa kehamilan.

Buku ini juga mengulas tentang pemanfaatan teknologi dalam layanan konseling jarak jauh, yang menjadi solusi bagi ibu hamil yang memiliki keterbatasan akses ke layanan kesehatan mental konvensional. Pembaca akan mendapatkan wawasan tentang berbagai metode konseling daring, etika pelaksanaan konseling, serta tantangan dan solusi yang mungkin dihadapi dalam implementasi layanan tersebut.

Sebagai penutup, buku ini menegaskan kembali pentingnya peran aktif keluarga dalam memberikan dukungan yang optimal selama masa kehamilan. Dukungan keluarga tidak hanya berperan dalam menjaga kesehatan mental ibu hamil tetapi juga menjadi kunci dalam menurunkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, serta meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi setelah kelahiran. Dengan membaca buku ini, diharapkan pembaca dapat memahami lebih dalam tentang pentingnya menjaga kesehatan mental selama kehamilan demi mewujudkan generasi yang sehat secara fisik, mental, dan emosional.



Buku Referensi "Pentingnya Kesehatan Mental dalam Kehamilan" hadir sebagai jawaban atas kebutuhan informasi tentang aspek psikologis yang sering terabaikan selama masa kehamilan.

Kehamilan adalah periode yang penuh perubahan fisik dan emosional, yang bila tidak ditangani dengan tepat, dapat memicu berbagai gangguan mental seperti depresi, kecemasan, hingga stres berkepanjangan. Melalui buku ini, para penulis secara komprehensif mengupas berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ibu hamil, termasuk perubahan hormon, dukungan keluarga, status ekonomi, serta pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh ibu hamil.

Secara rinci, buku ini menjelaskan pentingnya dukungan emosional selama masa kehamilan, baik dari pasangan, keluarga, maupun lingkungan sosial. Dukungan tersebut terbukti efektif dalam menurunkan risiko gangguan mental, meningkatkan kesejahteraan emosional ibu hamil, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang janin. Selain itu, berbagai strategi praktis seperti aktivitas fisik, prenatal yoga, meditasi, dan teknik relaksasi juga dibahas secara mendalam sebagai upaya menjaga keseimbangan mental dan emosional ibu selama masa kehamilan.

Buku ini juga mengulas tentang pemanfaatan teknologi dalam layanan konseling jarak jauh, yang menjadi solusi bagi ibu hamil yang memiliki keterbatasan akses ke layanan kesehatan mental konvensional. Pembaca akan mendapatkan wawasan tentang berbagai metode konseling daring, etika pelaksanaan konseling, serta tantangan dan solusi yang mungkin dihadapi dalam implementasi layanan tersebut.

Sebagai penutup, buku ini menegaskan kembali pentingnya peran aktif keluarga dalam memberikan dukungan yang optimal selama masa kehamilan. Dukungan keluarga tidak hanya berperan dalam menjaga kesehatan mental ibu hamil tetapi juga menjadi kunci dalam menurunkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, serta meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi setelah kelahiran.

Dengan membaca buku ini, diharapkan pembaca dapat memahami lebih dalam tentang pentingnya menjaga kesehatan mental selama kehamilan demi mewujudkan generasi yang sehat secara fisik, mental, dan emosional.

Penerbit:

**PT Optimal Untuk Negeri**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-10-9829-0



9

786231

098290